TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

"Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng"

Trách nhiệm - Chất lượng - Phát triển - Hội nhập
Responsibility - Quality - Development - Integration

TUẦN 1
12/2/2022

GIỚI THIỆU VỀ THỰC HÀNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

PGS.TS.BS.PHẠM LÊ AN
CNĐD. MAI NGUYỄN THANH TRÚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Mục tiêu

- Giải thích được định nghĩa về thực hành dựa trên bằng chứng (EBP)
- Xác định vai trò của EBP trong thực hành điều dưỡng
- Trình bày các mô hình của EBP
- Xác định các yếu tố khuyến khích sự phát triển, cản trở EBP





Tại sao chúng ta thay kim luồn sau 72h, việc thay sau 72h hay thay hàng ngày, việc nào tốt hơn



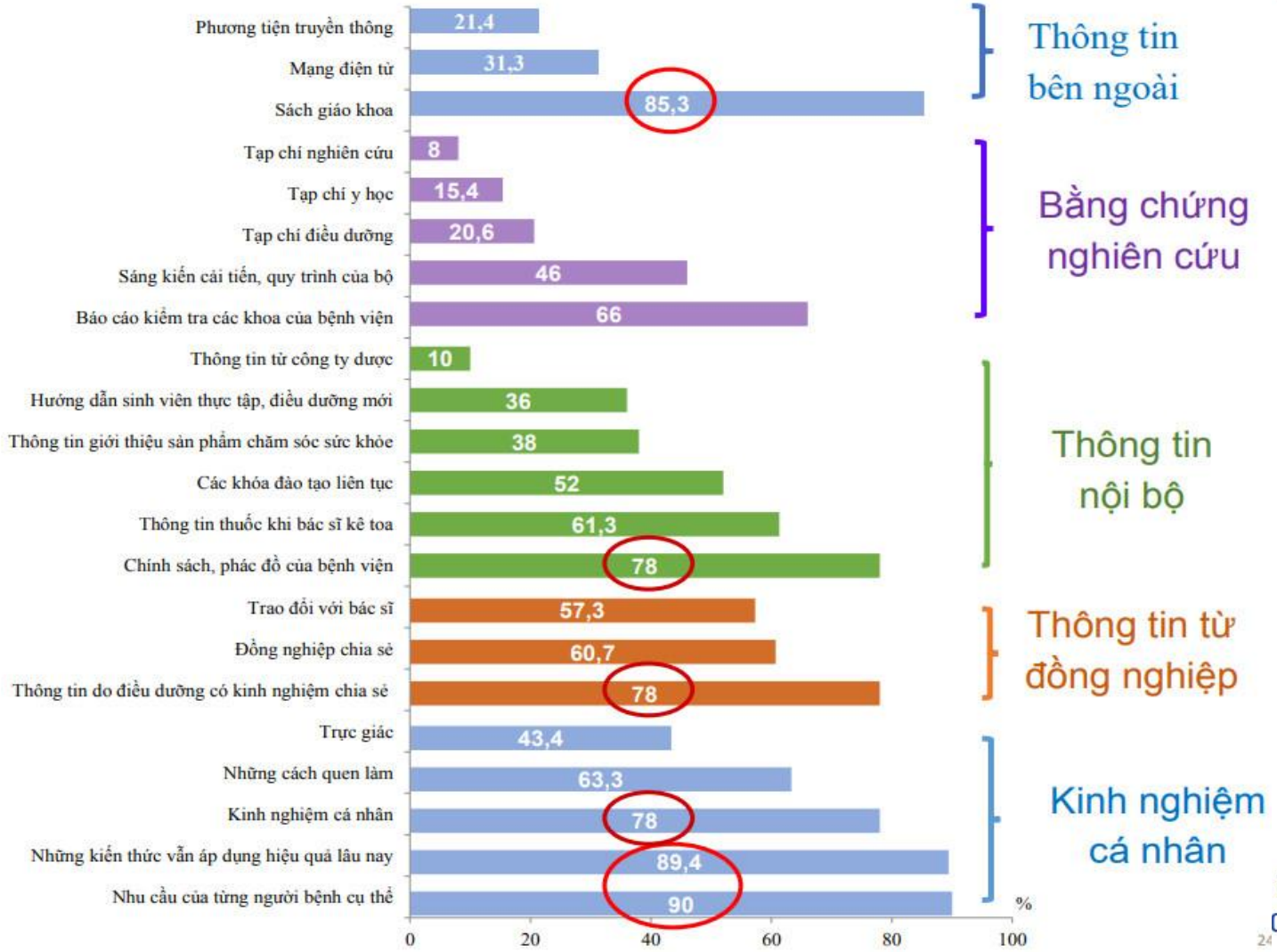
Tốt hơn

An toàn hơn

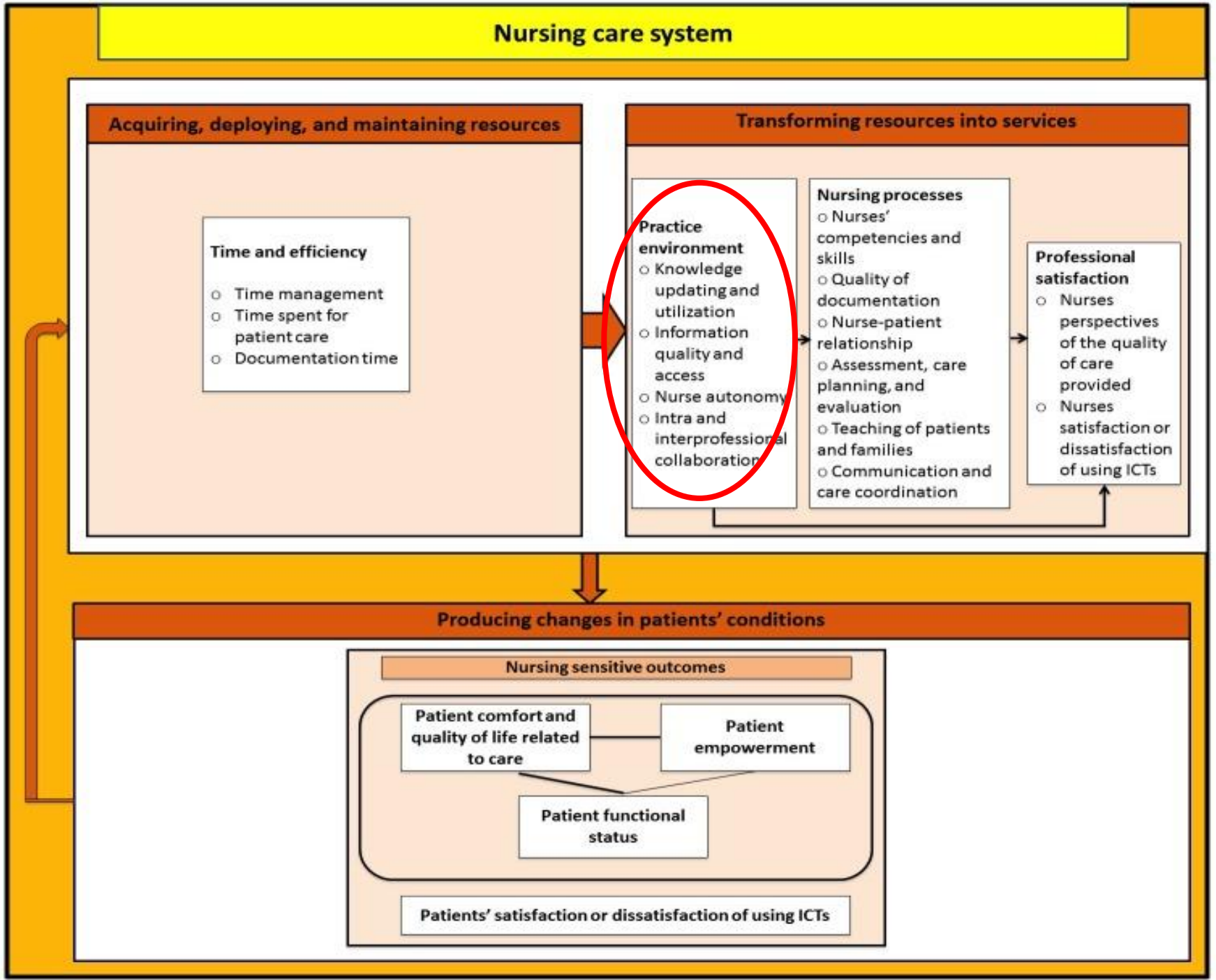
Tuân thủ tốt hơn

Bệnh nhân hài lòng hơn

Thông tin sử dụng khi chăm sóc bệnh nhân?



Đặng Thị Minh Phượng (2017)



Geneviève Rouleau (2017)

C Y DƯỢC CẦN THƠ
CINE AND PHARMACY

Why Is EBP important?

- Researchers at the Institute for Healthcare Improvement (IHI) developed three principles to improve both individual healthcare and the health of populations, while also reducing the overall cost of care. The “Triple Aim,” as it is called, became a priority for the United States with the passage of the Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) in 2010. The Triple Aim is defined as “improving the individual experience of care; improving the health of populations; and reducing the per capita costs of care for populations.” A fourth aim, to reduce burnout and improve the clinical experiences of nurses, has since been added.
- Research consistently demonstrates that EBP improves the delivery of healthcare, strengthens outcomes, diminishes geographical differences in care and cuts costs. Employing EBP has been found to increase overall job satisfaction, which in turn reduces burnout.
- In spite of its efficacy in meeting the Triple and Quadruple Aims, EBP is only gradually becoming the standard of carehe United States. Given its proven ability to greatly improve the quality of care while simultaneously reducing costs, it is critical to advance the adoption of EBP. Armed with the necessary knowledge and skills, nurses can be an integral part of EBP implementation as members of interdisciplinary teams and healthcare systems.

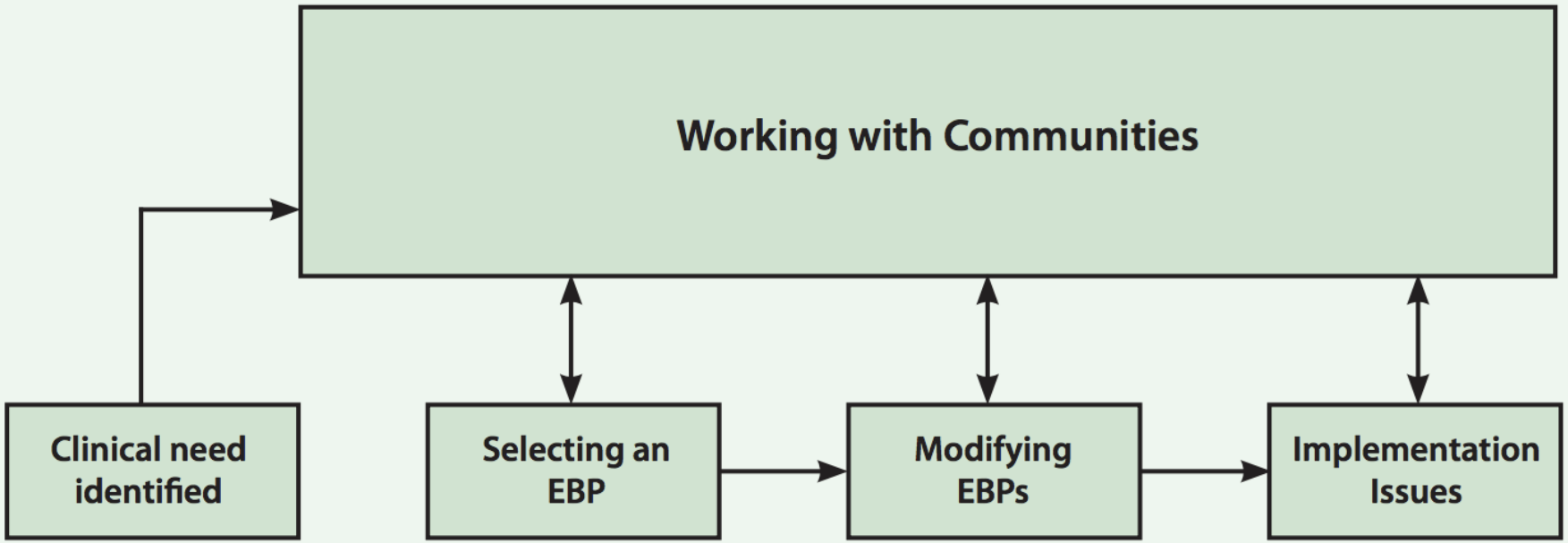
Why Is EBP important?

- Beginning with Florence Nightingale in the 1800s and evolving from within the medical community in the 1970s, evidence-based practice continues to advance and change along with the nursing discipline. Utilizing nursing best practice guidelines, reviewing and implementing applicable research evidence, and taking advantage of technological advances are all ways in which nursing can move forward as a well-informed discipline.
- Evidence-based practice is rooted in the premise that patient care should be informed by sound evidence. Nursing professionals utilize and synthesize the best evidence in order to inform their clinical practice and decision-making. According to the CNA, “decision-making in nursing practice is influenced by evidence and also by individual values, client choice, theories, clinical judgment, ethics, legislation and practice environments” (CNA, 2002, p.1).

What Does EBP Mean for Nurses?

- As an empowering approach to care, EBP gives nurses the tools they need to become change agents for improved healthcare outcomes. Embodying an ethic of problem-solving and inquiry, it begins with observation and the formulation of a question, continues through studious pursuit of an answer through research and integration into care and ideally results in improved conditions and outcomes, both locally and globally, as the findings are shared.
- Nurses employing EBP become the nexus between a wealth of medical research and practical experience on the ground. They are able to standardize care, decrease medical errors, and bring positive change to their patients, their communities and the world.
- Ultimately, EBP gives nurses the opportunity to take a more active role in shaping the practice of nursing in concert with other healthcare professionals and clinicians. It means living up to the example that Nightingale set and creating a better healthcare system from the inside.

Figure 1: The EBP Modification Process



- Identifying types of individuals that are needed for a successful working group
- Requesting individuals to serve on the working group
- Encouraging champions within the organization and community
- Establishing the collaborative process—communication and meetings
- Establishing working group goals and processes
- Putting the working group into action

- Identifying possible EBPs
- Evaluating the cultural appropriateness of EBPs
- Making a final EBP selection

- Breaking down the EBP into its components and determining which components to modify
- The process of modification
- Documenting modifications
- Trying out/piloting the modified EBP
- Evaluating the success of the modification

- Organizational readiness for change
- Understanding the organization's cultural competence

Culture is the way of life of a group of people. It encompasses behaviors, beliefs, values, and symbols that are accepted and passed along by communication and imitation from one generation to the next. Culture can be shaped by the society in which one lives. Large societies often encompass cultural variations which differentiate some members from the larger group. These can be based on domains such as age, race, ethnicity, class, gender, political affiliation, religion, geographic location, and/or sexual orientation, among other factors. Throughout the Toolkit, we refer to the local cultural group served by the EBP as the ***community***.

With this definition in mind, it is not difficult to understand that EBPs designed to address concerns of a given cultural group may not be suitable for those who differ from the dominant culture or for other cultures, thus creating a need for cultural modification.

Cultural Accommodation to an EBP involves modifying the way a practice is delivered so that it can be utilized with a particular culture or community (e.g., translating forms, using interpreters).

Cultural Adaptation to an EBP involves reviewing and changing the structure of a program or practice to more appropriately fit the needs and preferences of a particular cultural group or community.

It should be noted that both accommodations and adaptations for cultural groups are types of modifications to EBPs. In some situations, EBPs will require both accommodations and adaptations in order to meet the needs of the community of focus.

Translating Evidence: What we know

- Most EB Interventions are not implemented
- We have only begun to look at creating an atmosphere in the workplace for Evidence-Based Practice
- The organizational *Culture* and *Climate* influence both of these things

Translating Evidence: Some Definitions

Organizational Culture

- "the way things are done around here"
- The shared norms, beliefs and behavioral expectations that drive behavior and communicate what is valued in an organization

Summary of definitions from:

Hemelgarn, Glisson and James. (2006) Organizational culture and climate: implications for services and interventions research. *Clinical Psychology: Science and Practice.* 13(1).

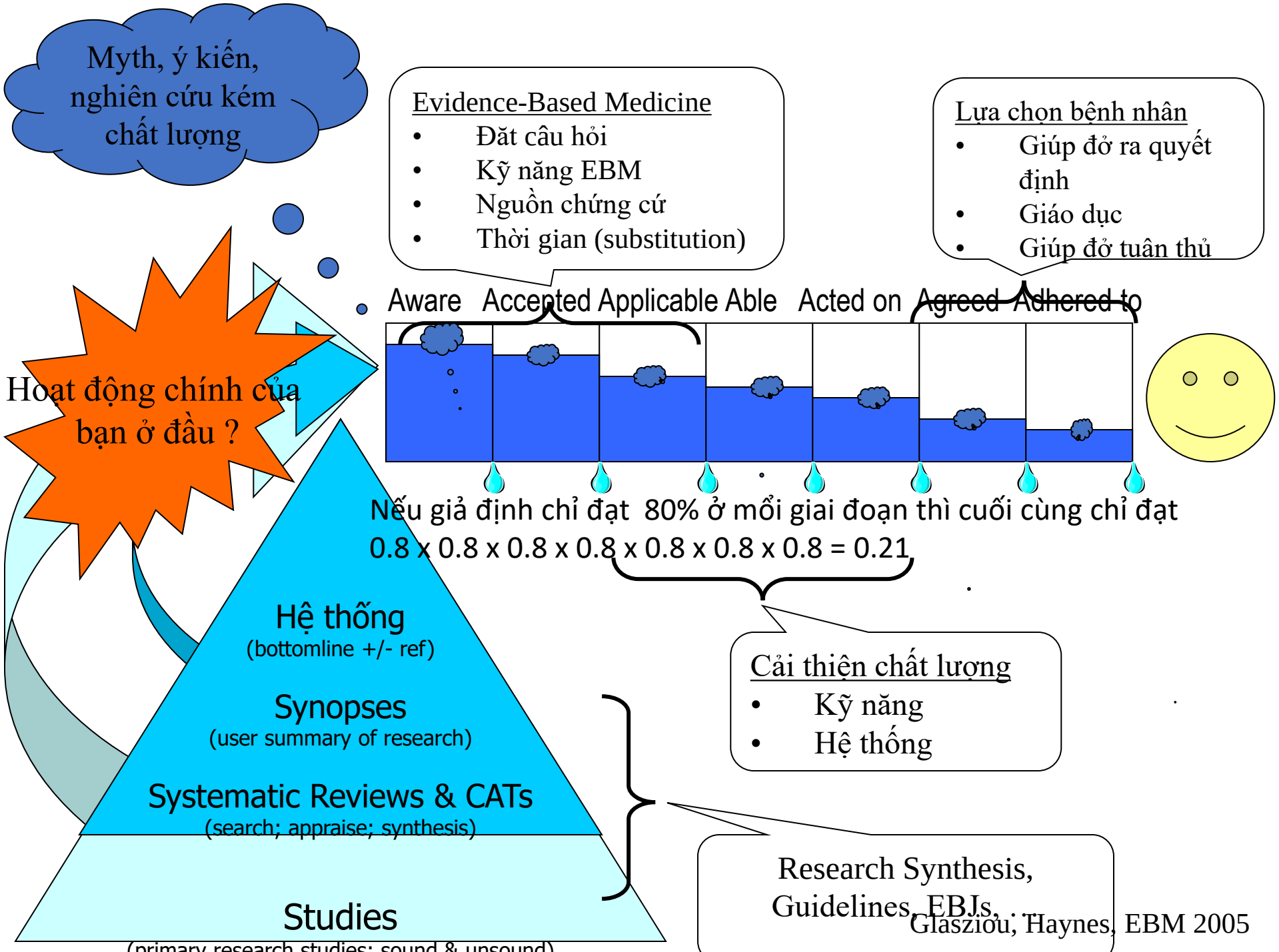
Translating Evidence: Some Definitions

Organizational Climate

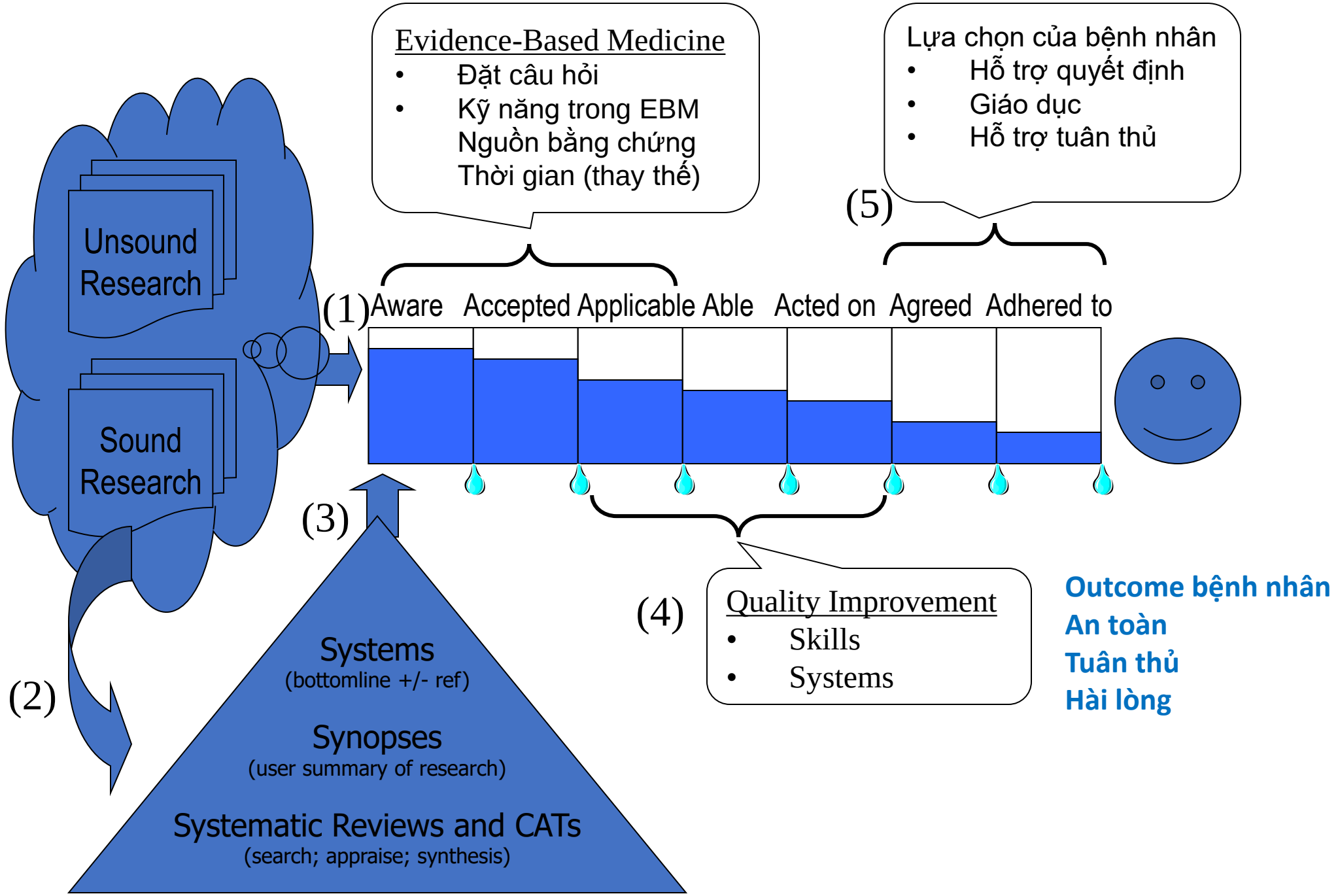
- "How it feels to work here"
- The agreed upon (i.e. not just individual) perception of the psychological impact of the work environment

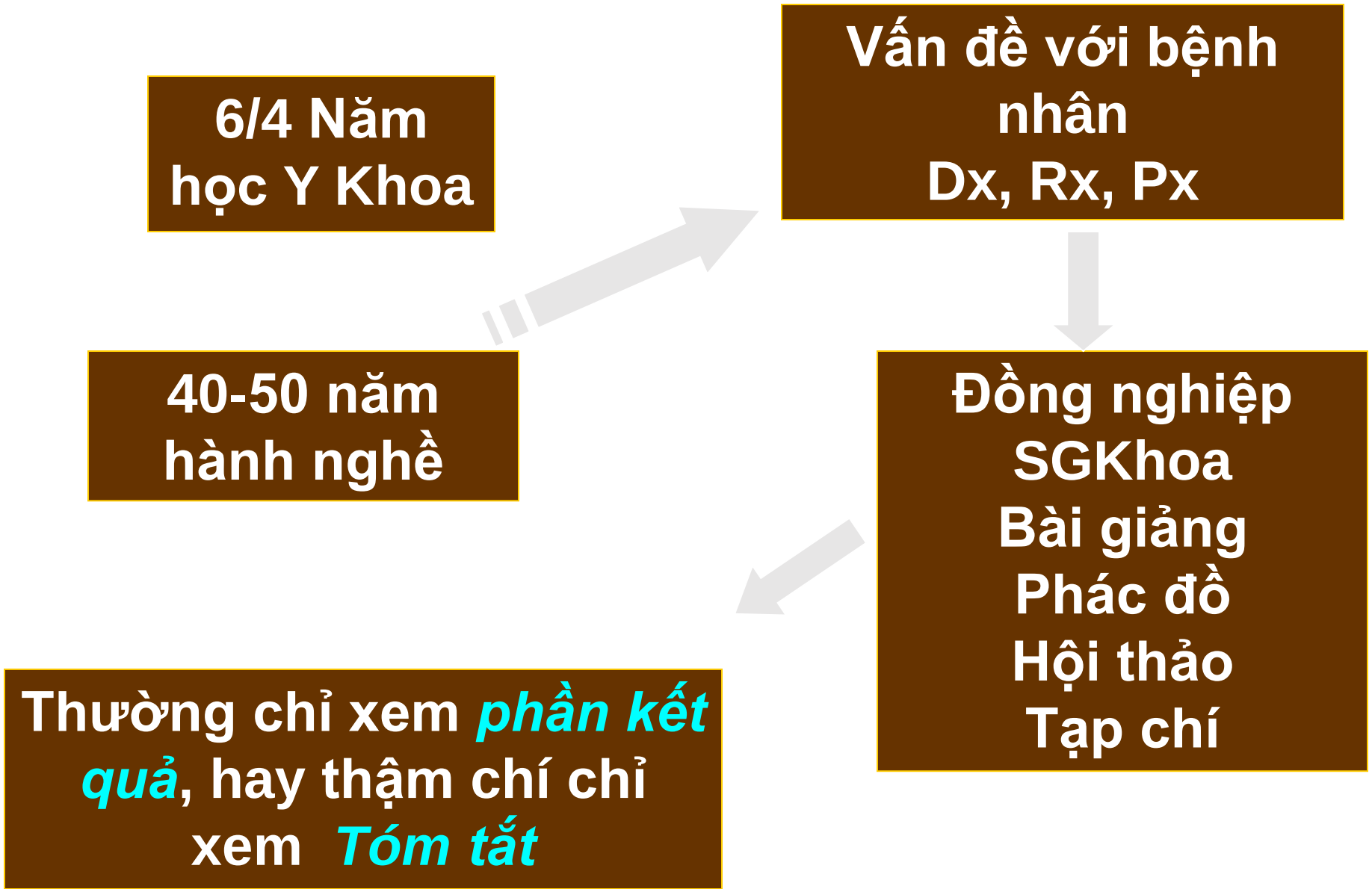
Summary of definitions from:

Hemelgarn, Glisson and James. (2006) Organizational culture and climate: implications for services and interventions research. *Clinical Psychology: Science and Practice.* 13(1).



Glasziou, Haynes, EBM 2005


Evidence-Based Medicine
• Đặt câu hỏi
• Kỹ năng trong EBM
Nguồn bằng chứng
Thời gian (thay thế)
Lựa chọn của bệnh nhân
• Hỗ trợ quyết định
• Giáo dục
• Hỗ trợ tuân thủ
(5)
(1)
Aware
Accepted
Applicable
Able
Acted on
Agreed
Adhered to
Unsound Research
Sound Research
(3)
(2)
Systems
(bottomline +/- ref)
Synopses
(user summary of research)
Systematic Reviews and CATs
(search; appraise; synthesis)
(4)
Quality Improvement
• Skills
• Systems
Outcome bệnh nhân
An toàn
Tuân thủ
Hài lòng


6/4 Năm học Y Khoa
Vấn đề với bệnh nhân Dx, Rx, Px
Đồng nghiệp SGKhoa Bài giảng Phác đồ Hội thảo Tạp chí
Thường chỉ xem phần kết quả, hay thậm chí chỉ xem Tóm tắt
40-50 năm hành nghề

Kiến thức mai một theo thời gian

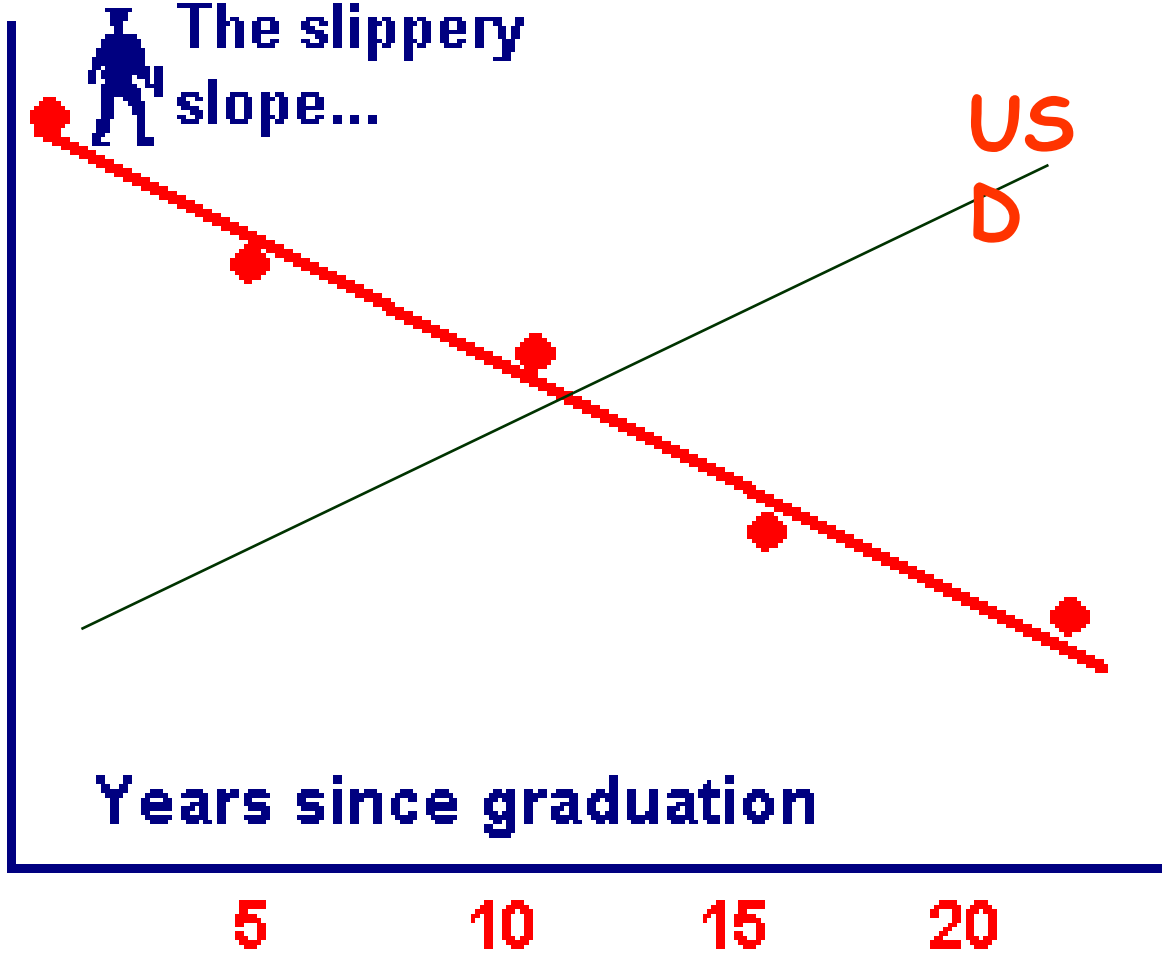
Knowledge of best hypertension care



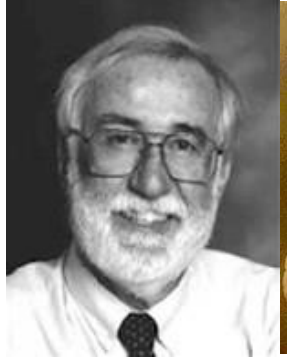
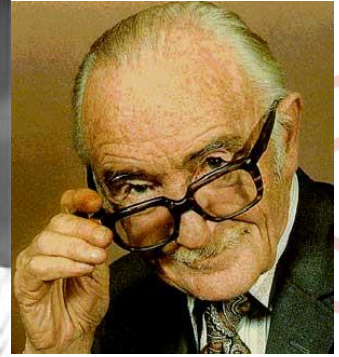
Shiri et al, CMAJ, 1993

r = -.54

p < 0.001



Người tiên phong


Những người tiên phong nổi tiếng của YHCC là **Avicenna** với quyển sách *The Canon of Medicine* in the 11th century[3,6]

- Although EBP has only recently found widespread integration in modern nursing practice, starting in the 1990s, its roots run deep in nursing history. While most of the literature credits physician Archie Cochrane in the 1970s as the originator of EBP, then called evidence-based medicine, some nurse researchers trace it back to Florence Nightingale. In the 1800s, her effort to improve patient outcomes in the face of unsanitary conditions by employing accurate observation and analysis is often considered the first example of EBP.
- While supervising the barrack hospital in Scutari, Turkey, during the Crimean war, Nightingale applied critical thinking skills, evidence and experimentation to improve patient health. She also used statistics to better anticipate morbidity and mortality in her patients. Although she lacked the wealth of research we have today, she was nevertheless a trailblazer for EBP in nursing.
- The common heritage that all nurses share, dating back to Nightingale, is a natural fit for EBP. Nurses considering an online RN to BSN should ensure the program they choose includes EBP as an essential part of the curriculum.

và A. **Cochrane**, D. **Sackett**, and G. **Guyatt** trong thế kỷ 20[1].

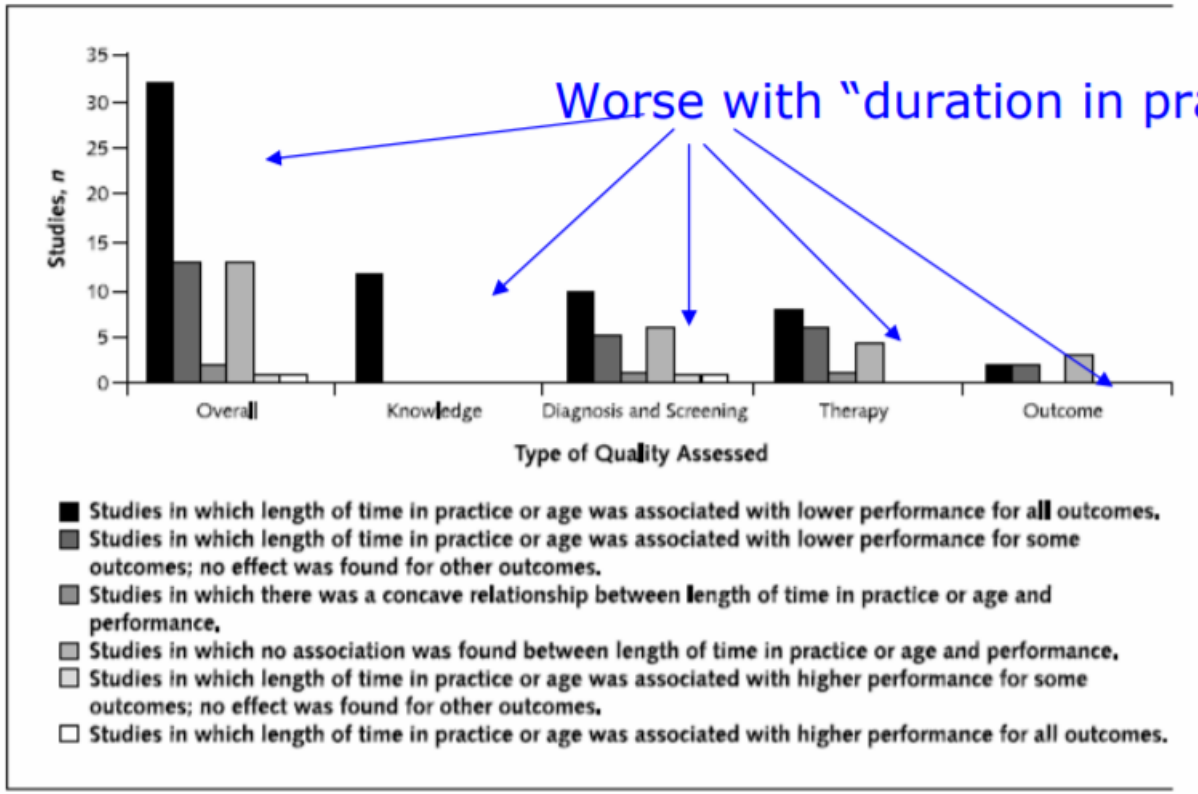
“Most nurses practice according to what they learned in nursing school, their experience and what colleagues share in the clinical setting”

Estabrooks, 1998;2003 and Pravikoff 2005

Systematic Review: The Relationship between Clinical Experience and Quality of Health Care

Niteesh K. Choudhry, MD; Robert H. Fletcher, MD, MSc; and Stephen B. Soumerai, ScD

Figure 2. Distribution of study results relating physician age to clinical performance in various domains.



EBP là gì?

- Năm 1972, Archie Cochrane và cộng sự tiến hành nghiên cứu cho thấy **"khoảng trống giữa lâm sàng và nghiên cứu"**
- Những năm 1980, thuật ngữ Y học thực chứng (EBM)
- Những năm đầu 1990, thuật ngữ Thực hành dựa trên bằng chứng (EBP) xuất hiện tại Anh

EBP là gì?

- Là sự kết nối có hệ thống giữa các bằng chứng được tạo ra một cách khoa học với kiến thức thực hành để đạt được sự thay đổi trong một thực hành cụ thể vì bệnh nhân được xác định rõ (French 1999).

- Là sự tích hợp bằng chứng nghiên cứu tốt nhất trong y học với trải nghiệm lâm sàng và các giá trị, mong muốn của người bệnh và việc sử dụng hợp lý, rõ ràng, chính xác bằng chứng hiện có trong việc ra quyết định chăm sóc người bệnh (Sackett 1996)

EBP là gì?

- **Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng:** là một cách cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng được hướng dẫn bởi sự tích hợp của kiến thức khoa học tốt nhất hiện có với chuyên môn điều dưỡng (NLM PubMed).

Làm chủ thông tin: Sự hữu dụng = tính thích hợp x giá trị/ công sức (Công thức của BS DC Slawson

J.Fam Pract 1994:38:490-499) POEMs quan tâm hơn là quan tâm đến DOEs

EBP là gì?


Research

≠


Clinical Expertise
Best Research Evidence
EBP
Patient Values & Preferences

≠


Quality Improvement in Nursing
Review data
Evaluate nursing performance
Identify areas for improvement
Formulate goals
Improve patient care and work environment
(American Nurses Association, 2011)

EBP là gì?

- Sử dụng cân nhắc bằng chứng hiện có để ra quyết định chăm sóc BN
- Một cách giải quyết vấn đề với thực hành lâm sàng chăm sóc Nội ngoại trú
- **Dựa trên:**
  1. Kinh nghiệm lâm sàng và chuyên môn tại chổ
  2. Nhu cầu và tình trạng của bệnh nhân
  3. Nghiên cứu lâm sàng



EBP là gì?

*** Nghiên cứu lâm sàng:**

- Khoa học cơ bản
- Lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng:
  - ➢ Tiên lượng
  - ➢ Chẩn đoán
  - ➢ Hiệu quả và an toàn điều trị, chăm sóc
  - ➢ Hồi phục chức năng

*** Kinh nghiệm lâm sàng:**

- Đóng vai trò quan trọng, bổ sung cho việc lựa chọn các bằng chứng nghiên cứu
- Hỗ trợ cho việc xác định các bằng chứng (hoặc phác đồ điều trị, hướng dẫn chăm sóc) có thể áp dụng cho bệnh nhân không, nếu có thể thì áp dụng như thế nào?

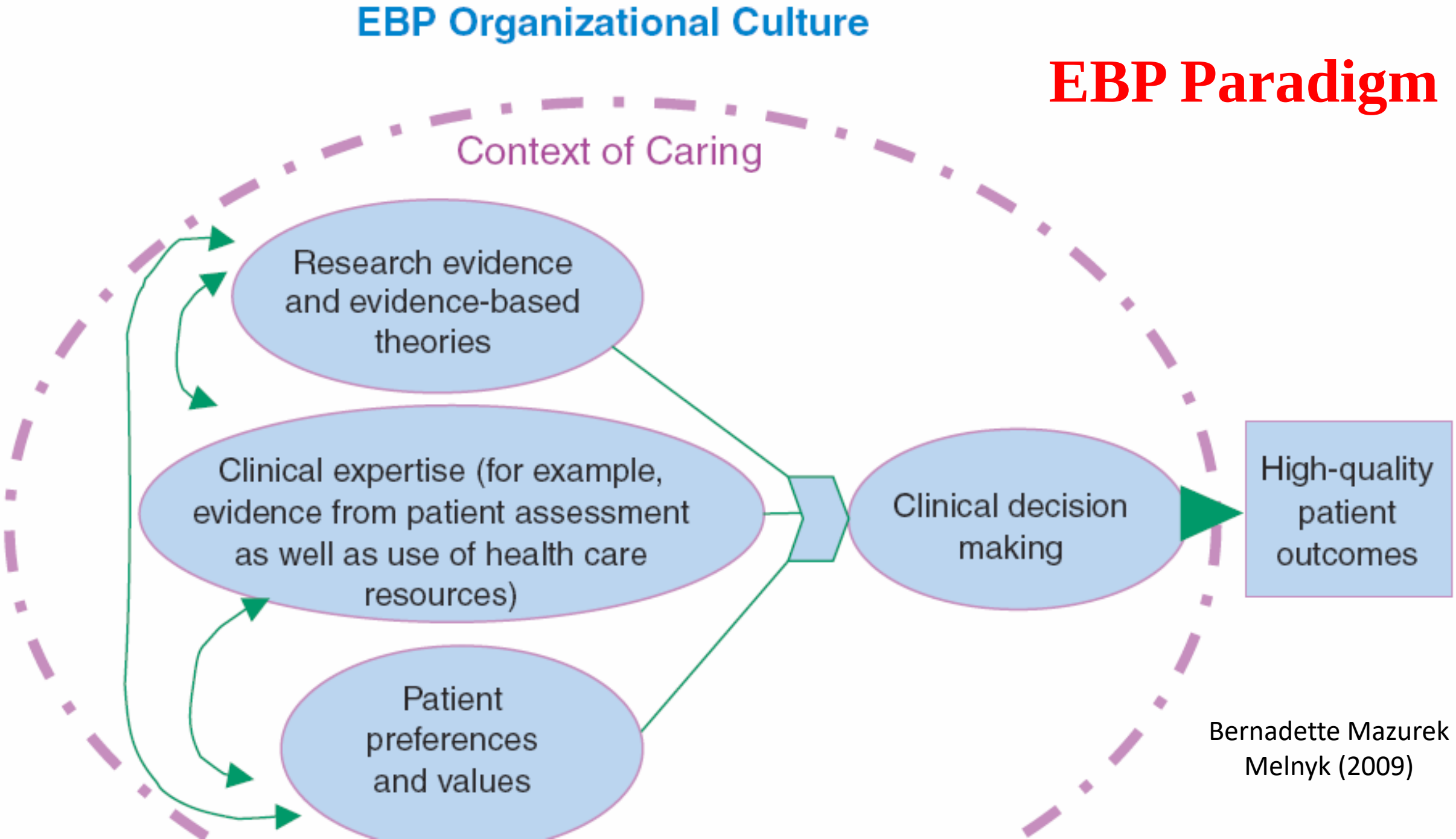
EBP là gì?

*** Kỳ vọng của bệnh nhân**

- Là những mối quan tâm của bệnh nhân, kỳ vọng trong quá trình chăm sóc và điều trị BioPsychoSocial model + Patient center care
- Đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc và điều trị = tuân thủ/ hành vi
- Cần có phương pháp và kế hoạch thực hiện cụ thể

- EBP không chỉ tập trung vào các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
- EBP không tập trung vào số liệu thống kê
- EBP không tìm kiếm hiệu quả về chi phí
- EBP không phải là "mì ăn liền" trong y khoa
- EBP không phải có ý định hạn chế quyền tự chủ trong điều trị và chăm sóc

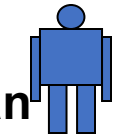
EBP Paradigm



Bernadette Mazurek Melnyk (2009)

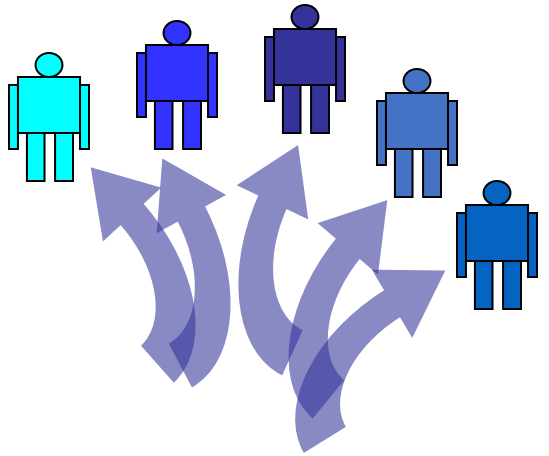
Thực hành EBP

Vấn đề
Bệnh nhân



Hỏi

Hành động &
Lượng giá



Tìm chứng cứ

Các nguyên lý thực hành
Y học chứng cứ

Đánh giá

Áp dụng

Evidence alone does not decide – combine with other knowledge and values

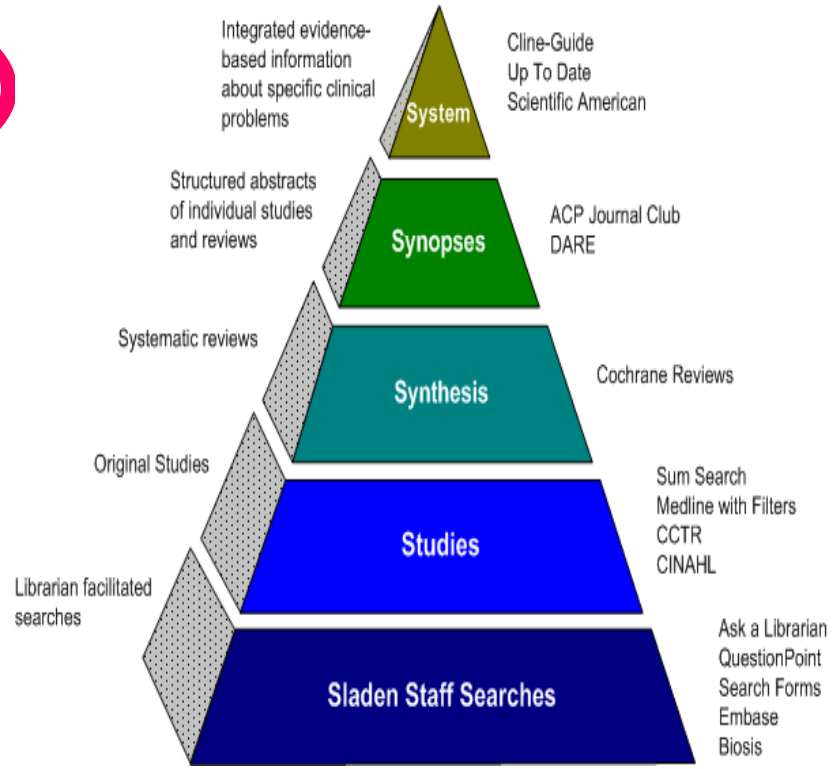
CÁC THÀNH TỐ RA QUYẾT ĐỊNH LÂM SÀNG

Hòan cảnh lâm sàng

Chuyên gia lâm sàng

Tham chiếu
bệnh nhân
và hành động

Chứng cứ
nghiên cứu

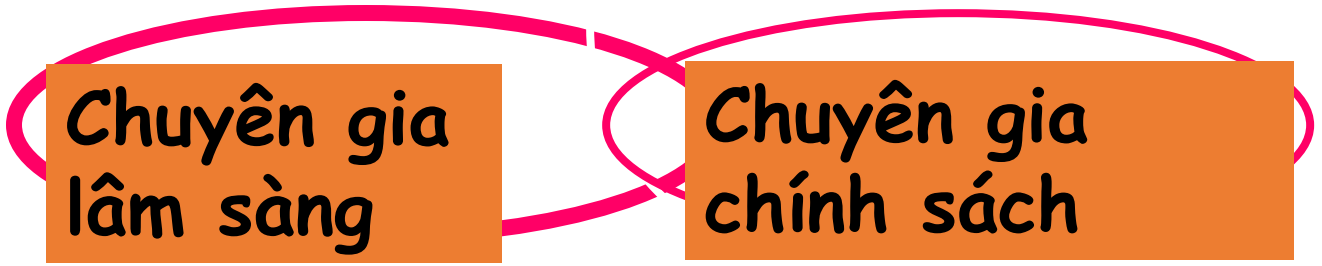


Brian Haynes '4S' model for searching

Mối liên quan giữa quyết định lâm sàng và chính sách

Bệnh cảnh
Lâm sàng

Các nguồn
tài nguyên

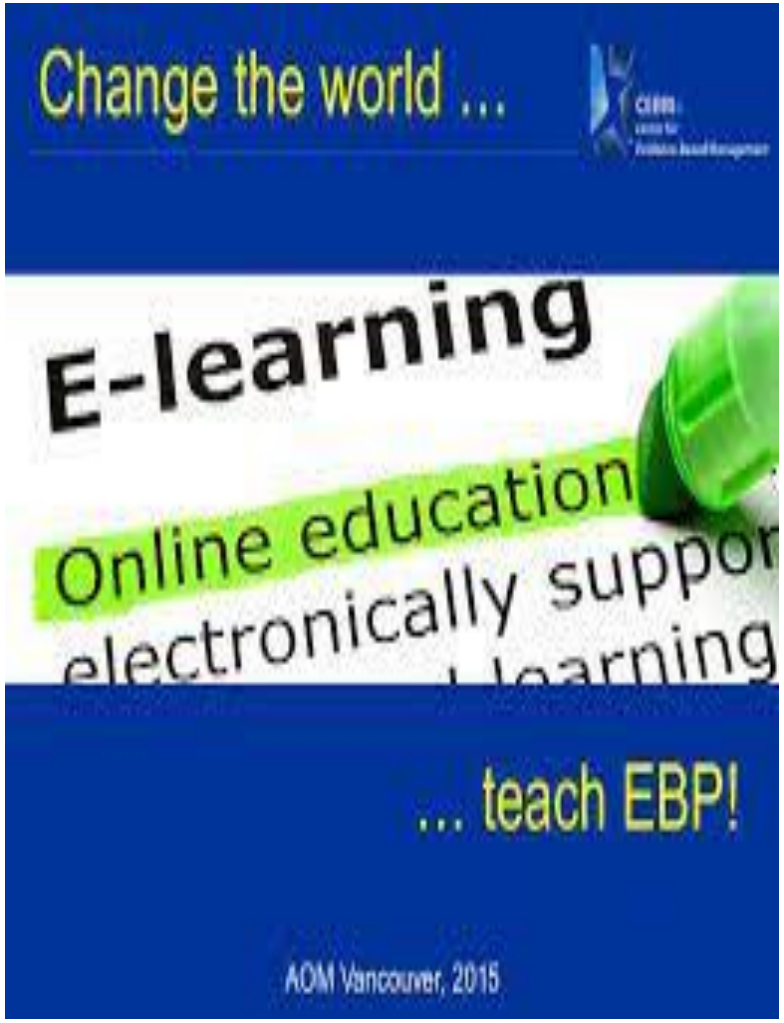


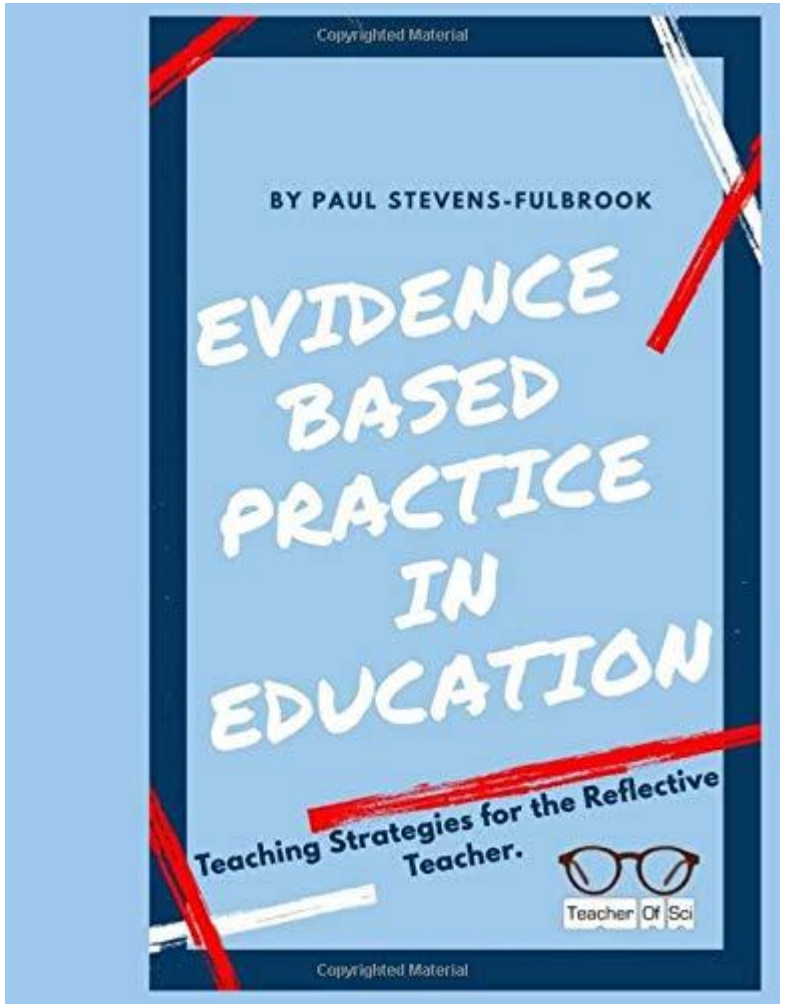
Tham chiếu
Bệnh nhân
Và Hành động

Bằng chứng
Nghiên cứu

Các giá
Trị xã hội


WORLD
EVIDENCE-BASED
HEALTHCARE DAY
2020
ebhc
20 OCTOBER 2020
#WorldEBHCDay | worldebhcday.org | #EvidencetoImpact


Change the world ...
E-learning
Online education
electronically suppor
learning
... teach EBP!
AOM Vancouver, 2015

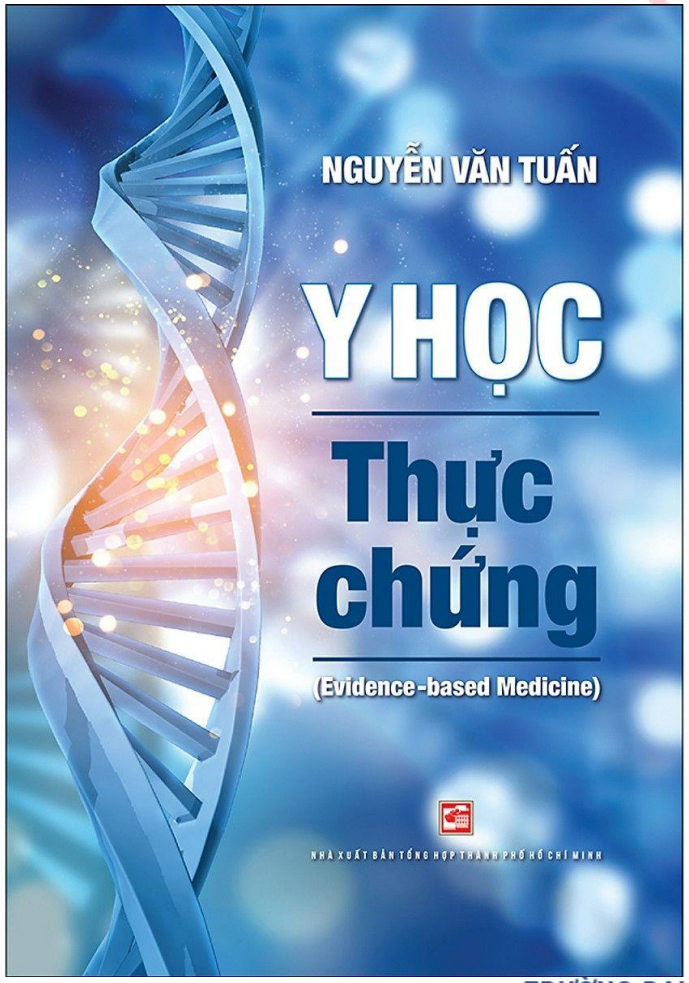

Copyrighted Material
BY PAUL STEVENS-FULBROOK
EVIDENCE BASED PRACTICE IN EDUCATION
Teaching Strategies for the Reflective Teacher.
Teacher Of Sci
Copyrighted Material

Tổ chức áp dụng EBP

- Agency for Healthcare Quality and Research (AHRQ)
- Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)
- Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
- U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)
- National Quality Forum (NQF)
- Institute for Healthcare Improvement (IHI)
- …….

Việt Nam


KHÁI NIỆM VỀ Y HỌC CHỨNG CỨ


NGUYỄN VĂN TUẤN
Y HỌC
Thực chứng
(Evidence-based Medicine)
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



“EBP và lịch sử điều dưỡng”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

BỘ Y TẾ

CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng4 năm 2012 của Bộ Y tế)

Hà Nội, tháng 4 năm 2012

Tiêu chuẩn 21: Cải tiến chất lượng chăm sóc và quản lý nguy cơ trong môi trường chăm sóc

Tiêu chí 1: Nhận thức được sự cần thiết về các hoạt động bảo đảm chất lượng, cải tiến chất lượng thông qua sự nghiên cứu, phản hồi và đánh giá thực hành thường xuyên.
Tiêu chí 2: Phát hiện, báo cáo và đưa ra các hành động khắc phục phù hợp các nguy cơ trong môi trường chăm sóc người bệnh
Tiêu chí 3: Nhận phản hồi từ người bệnh, gia đình và các đối tượng liên quan để cải tiến chất lượng các hoạt động chăm sóc.
Tiêu chí 4: Áp dụng các phương pháp cải tiến chất lượng phù hợp.
Tiêu chí 5: Tham gia các hoạt động cải tiến chất lượng tại cơ sở.
Tiêu chí 6: Chia sẻ các thông tin liên quan đến tình trạng người bệnh với các thành viên trong nhóm chăm sóc.
Tiêu chí 7: Bình phiếu chăm sóc để cải tiến và khắc phục những tồn tại về chuyên môn và thủ tục hành chính.
Tiêu chí 8: Đưa ra những đề xuất phù hợp về các biện pháp chăm sóc và phòng ngừa bệnh.
Tiêu chí 9: Sử dụng bằng chứng áp dụng vào thực hành chăm sóc để tăng cường sự an toàn trong chăm sóc người bệnh.

Tiêu chuẩn 22: Nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng

Tiêu chí 1. Xác định và lựa chọn các lĩnh vực và vấn đề nghiên cứu phù hợp, cần thiết và khả thi.
Tiêu chí 2: Áp dụng các phương pháp phù hợp để tiến hành nghiên cứu những vấn đề đã lựa chọn.
Tiêu chí 3: Sử dụng phương pháp thống kê thích hợp để phân tích và diễn giải dữ liệu thu thập được.

BỘ Y TẾ

Số: 342/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tài liệu

"Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam" kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng các Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh; Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp đào tạo hộ sinh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

NĂNG LỰC VỀ XÃ HỘI, VĂN HÓA VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH

NĂNG LỰC 1

Hộ sinh phải có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực: sản khoa, sơ sinh, xã hội, y tế công cộng và đạo đức nghề nghiệp. Những kiến thức và kỹ năng này là nền tảng để chăm sóc thích hợp cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và gia đình của họ phù hợp với các yếu tố văn hóa của cộng đồng.

A. KIẾN THỨC

CƠ BẢN

Tiêu chí 1.A.1. Hiểu biết/ có kiến thức về cộng đồng và các vấn đề liên quan đến sức khoẻ cộng đồng (như mức thu nhập, văn hóa, giáo dục, cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh, nhà ở, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, mô hình bệnh tật, các vấn đề sức khoẻ thường gặp, những nguy cơ phổ biến ảnh hưởng tới sức khỏe).

Tiêu chí 1.A.2. Nhận thức được việc sử dụng các chiến lược nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật chính là nguyên tắc chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng.

Tiêu chí 1.A.3. Xác định được nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây tử vong và tàn tật cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tại cộng đồng và các chiến lược làm giảm những nguyên nhân này.

Tiêu chí 1.A.4. Có kiến thức về phương pháp thẩm định những trường hợp tử vong mẹ và những trường hợp có nguy cơ tử vong mẹ.

Tiêu chí 1.A.5. Trình bày được nguyên tắc cơ bản của dịch tễ học, chẩn đoán cộng đồng và sử dụng những nguyên tắc này trong cung cấp dịch vụ.

Tiêu chí 1.A.6. Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, các phương pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, các phương pháp phòng ngừa chuẩn trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Tiêu chí 1.A.7. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu khoa học, thực hành dựa vào bằng chứng, giải thích được các tài liệu y văn, các số liệu thống kê, các kết quả nghiên cứu.

Tiêu chí 1.A.8. Giải thích được các chỉ số về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tiêu chí 1.A.9. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của giáo dục sức khỏe, thiết lập mối quan hệ tốt với phụ nữ, bà mẹ và gia đình, tuyên truyền thông tin có hiệu quả về

BỘ Y TẾ
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA

Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (Nursing specialized in midwifery)

Mã ngành: 7720301 - Trình độ đào tạo: Đại học

Số năm đào tạo: 4 năm – Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4304/QĐ-ĐHYD ngày 16/11/2020

của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Cử nhân Hộ sinh có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo Chuẩn năng lực nghề Hộ sinh ở trình độ đại học; có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ dưới 5 tuổi nói riêng.

B. CHUẨN ĐẦU RA

I. Yêu cầu về kiến thức

C1. Áp dụng những kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên, chính trị, xã hội và chuyên ngành giúp nhận định kế hoạch chăm sóc thích hợp trong lĩnh vực sức khoẻ sinh sản, sơ sinh và phát triển kiến thức mới.

II. Yêu cầu về kỹ năng

C2. Thực hiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và bà mẹ trước khi mang thai, trong thai kỳ, trong chuyển dạ và sau sinh dựa vào bằng chứng với tư duy phản biện.

C3. Thiết kế chương trình giáo dục sức khỏe phù hợp với văn hóa cộng đồng, nâng cao sức khỏe gia đình, hỗ trợ việc kế hoạch hóa gia đình hoặc kết thúc thai nghén theo qui định của luật pháp và hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

C4. Thể hiện tốt kỹ năng giao tiếp, phối hợp có hiệu quả với bác sĩ, đồng nghiệp, khách hàng. Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm trong học tập và công tác chăm sóc, tư vấn người bệnh và gia đình họ. Thích nghi với môi trường làm việc thực tế, đa dạng luôn thay đổi và nhiều thử thách.

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Chuẩn đầu ra 1: Tuân thủ chính sách pháp luật và có trách nhiệm với xã hội.

Chuẩn đầu ra 2: Ứng dụng ít nhất một ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong giao tiếp, thu thập thông tin và thực hành nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra 3: Có sức khỏe và phát triển được năng lực tự học, tự nghiên cứu, các kỹ năng mềm để thực hiện và phát triển nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra 4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng điều dưỡng để nhận định được tình trạng của đối tượng chăm sóc.

Chuẩn đầu ra 5: Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc hiệu quả các bệnh thường gặp.

Chuẩn đầu ra 6: Phát hiện sớm và phối hợp thực hiện sơ cứu, cấp cứu hiệu quả các tình huống cấp cứu.

Chuẩn đầu ra 7: Tham gia công tác quản lý hành chính, trang thiết bị y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn.

Chuẩn đầu ra 8: Thực hiện công tác giáo dục, quản lý và chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.

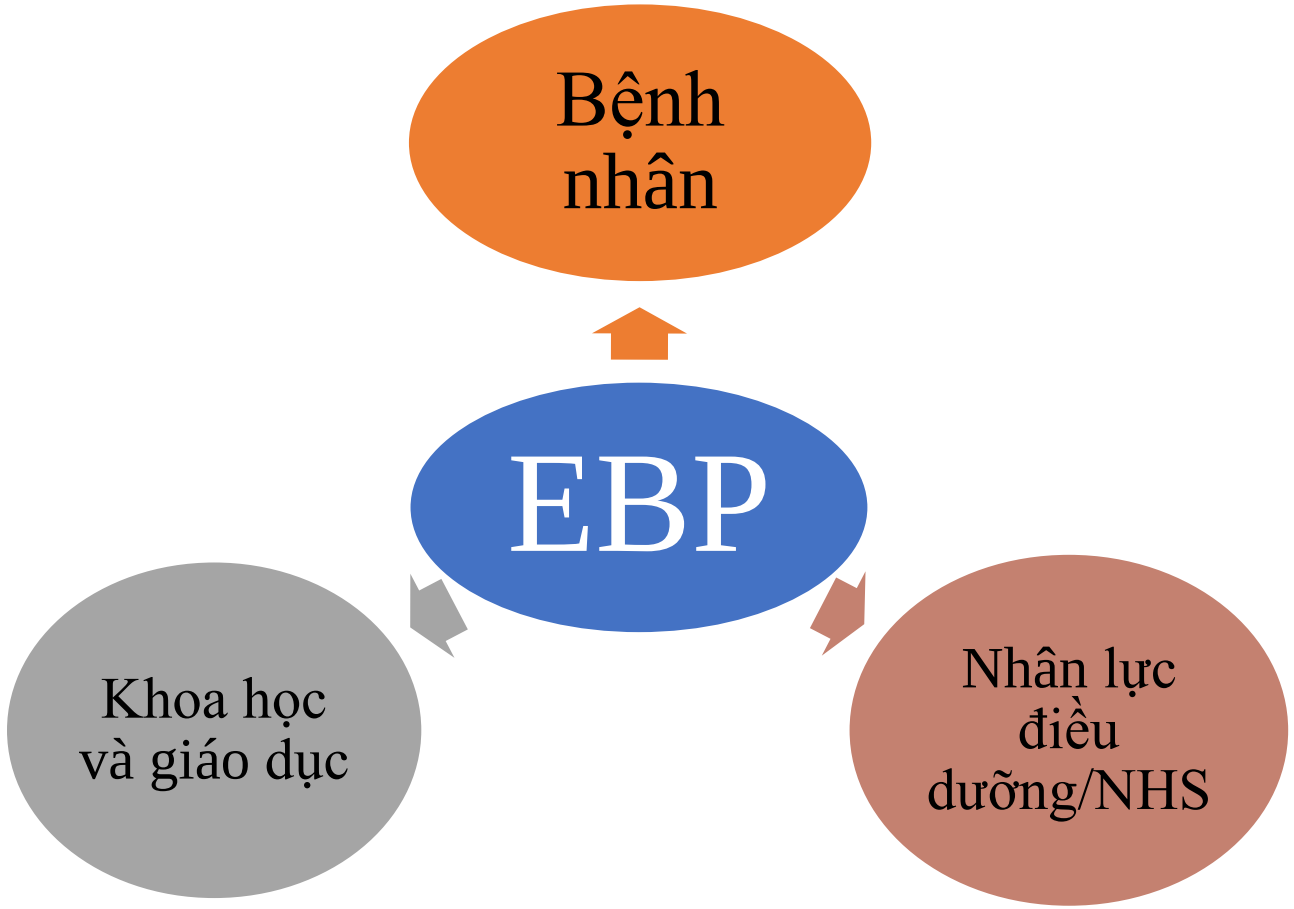
Chuẩn đầu ra 9: Phân tích được cơ cấu tổ chức và các nguyên lý quản lý y tế trong thực hành nghề nghiệp.

EBP trong thực hành điều dưỡng

"*EBP in nursing is a way of providing nursing care that is guided by the integration of the best available scientific knowledge with nursing expertise. This approach requires nurses to critically assess relevant scientific data or research evidence and to implement high quality interventions for nursing practice*"

(NLM Practice)

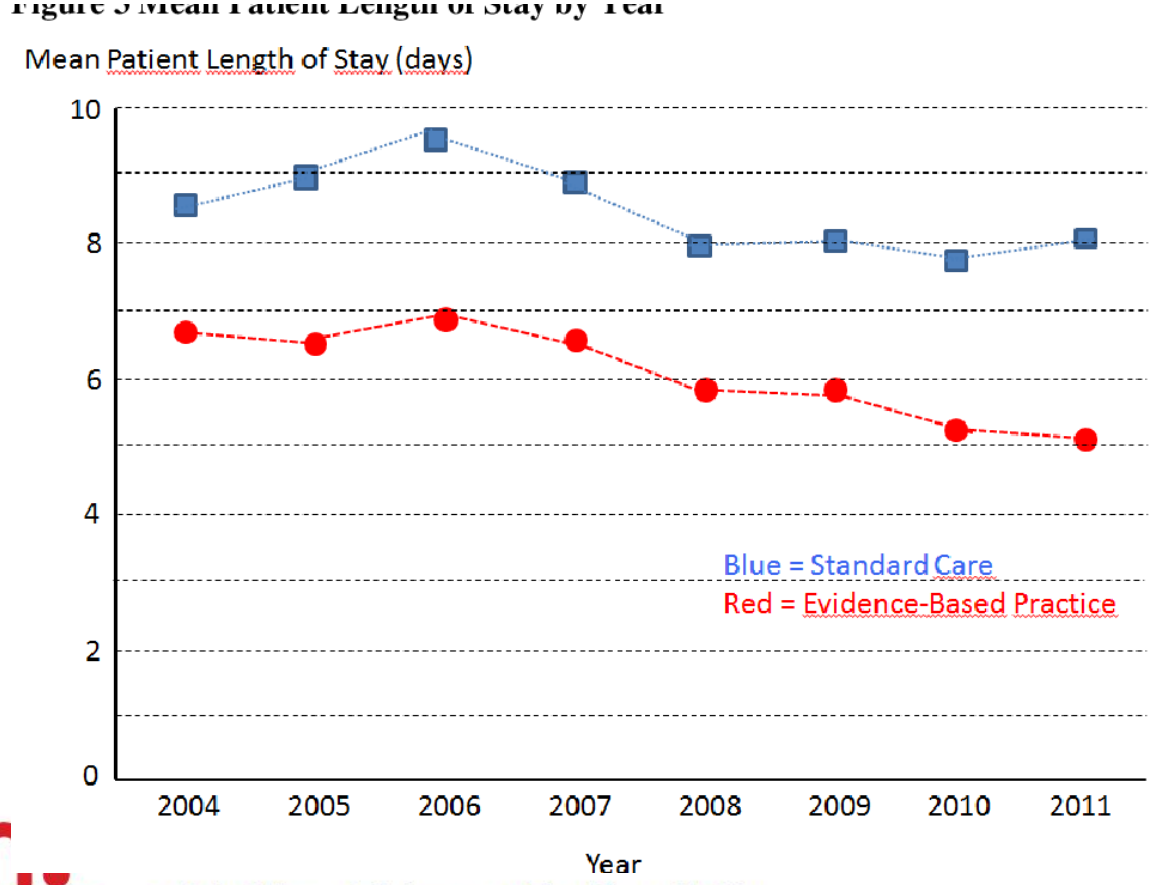
Tại sao thực hành dựa trên bằng chứng?



Tại sao thực hành dựa trên bằng chứng

- Cung cấp thông tin
- Tạo sự nhất quán trong chăm sóc
- Cải thiện kết quả chăm sóc bệnh nhân
- Thực hành tốt “lấy bệnh nhân làm trung tâm”
- Tăng sự tự tin cho nhân viên y tế
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định đúng đắn và rõ ràng hơn
- Đóng góp vào khoa học điều dưỡng
- Cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao
- Cho thấy những lỗ hổng về kiến thức và những mâu thuẫn trong bằng chứng

Hiệu quả của EBP trong thực hành lâm sàng



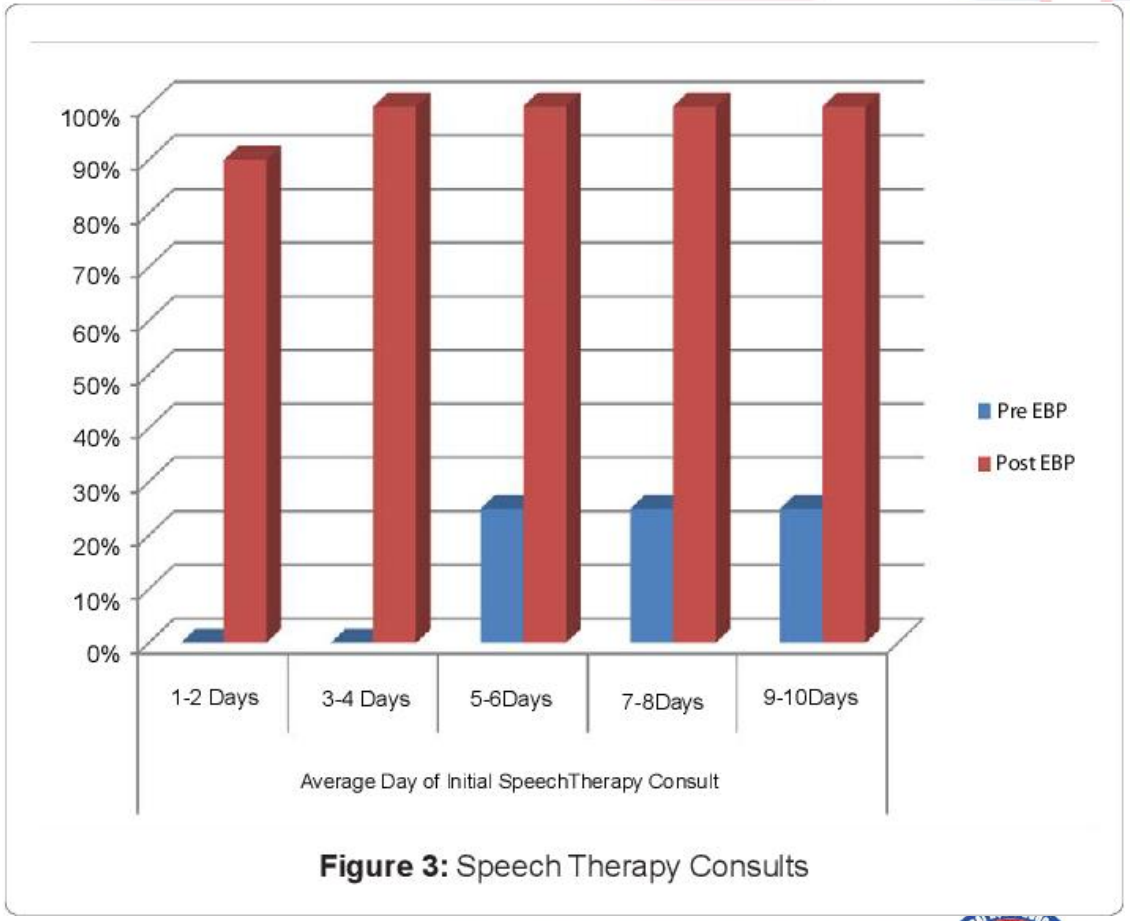
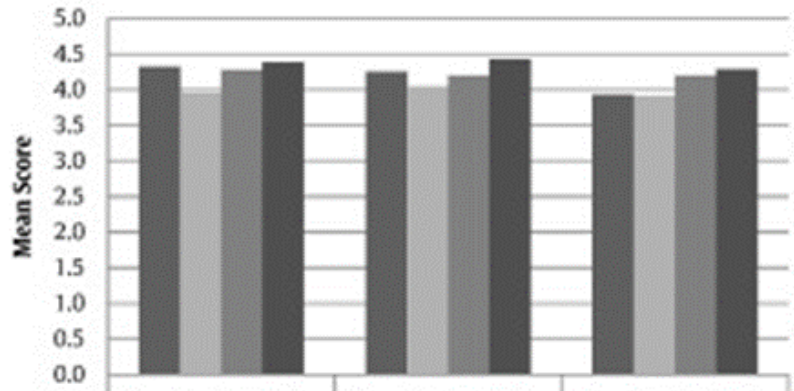
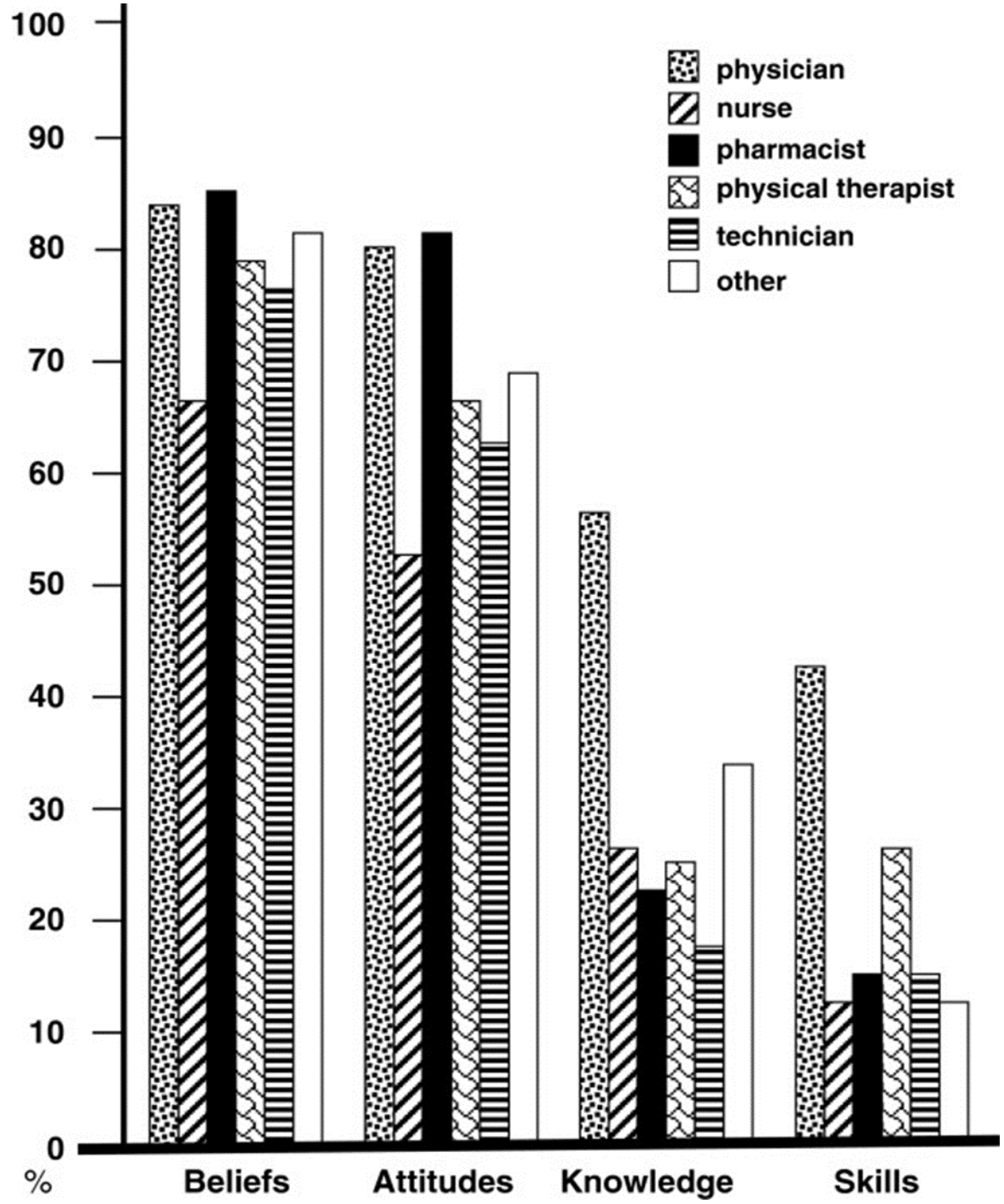


Figure 3: Speech Therapy Consults

Nursing Journal Club Participants Evaluation of Skills in Appraising Research and Evidence



Journal Club Session	Appraises Research Based on Levels of Evidence	Summarize Research Findings	Translate Findings into Practice
Professional Image (N=28)	4.32	4.25	3.93
Alarm Fatigue (N=23)	3.96	4.04	3.91
Quiet Hospitals (N=25)	4.28	4.20	4.20
Nurse Communication (N=21)	4.38	4.43	4.29



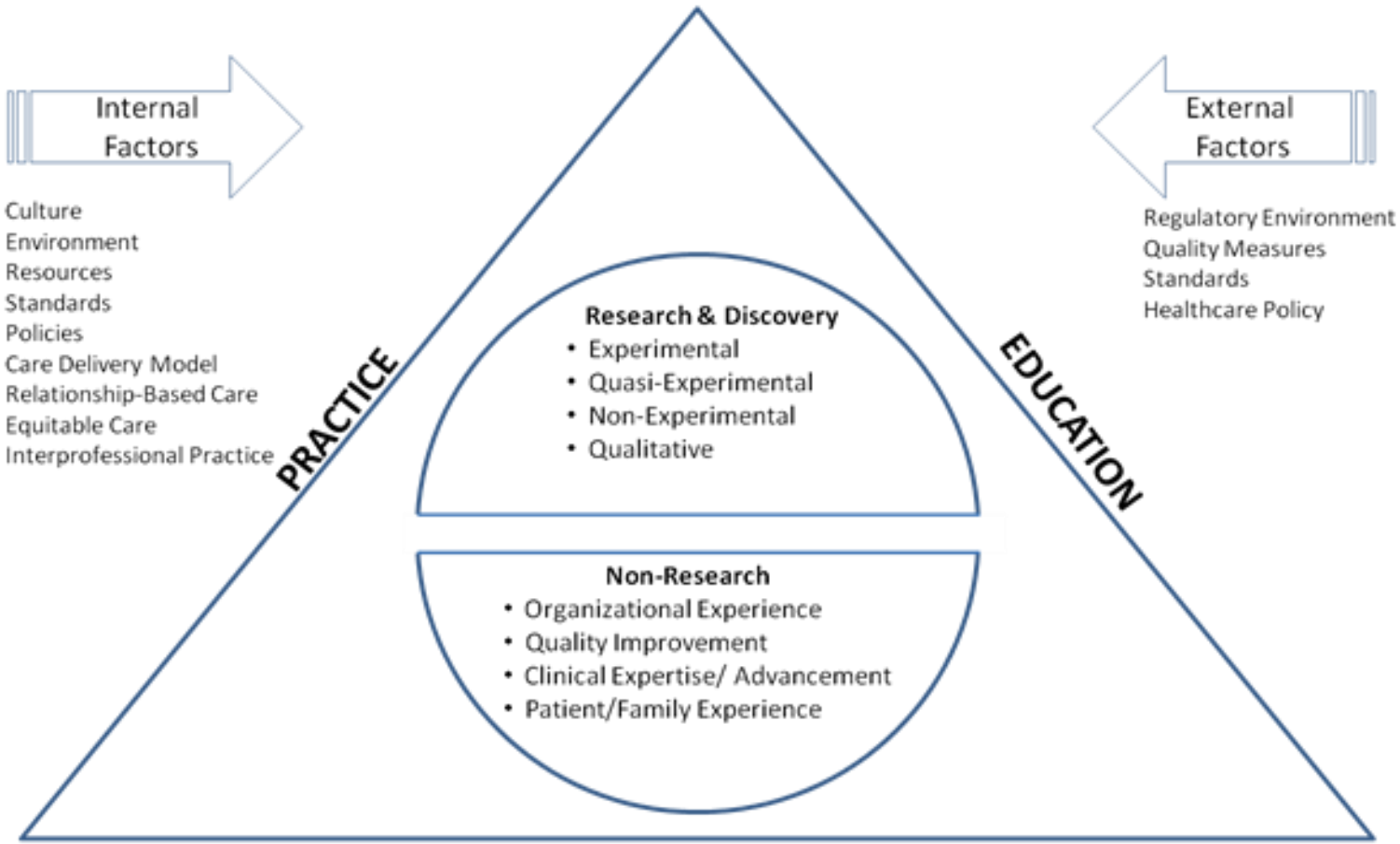
Mô hình EBP

- **John Hopkins Nursing EBP Model**

"*Được sử dụng như một khuôn khổ để hướng dẫn việc tổng hợp và truyền tarii các bằng chứng vào thực tế*" (Newhouse, Dearholt, Poe, Pugh and White 2007).

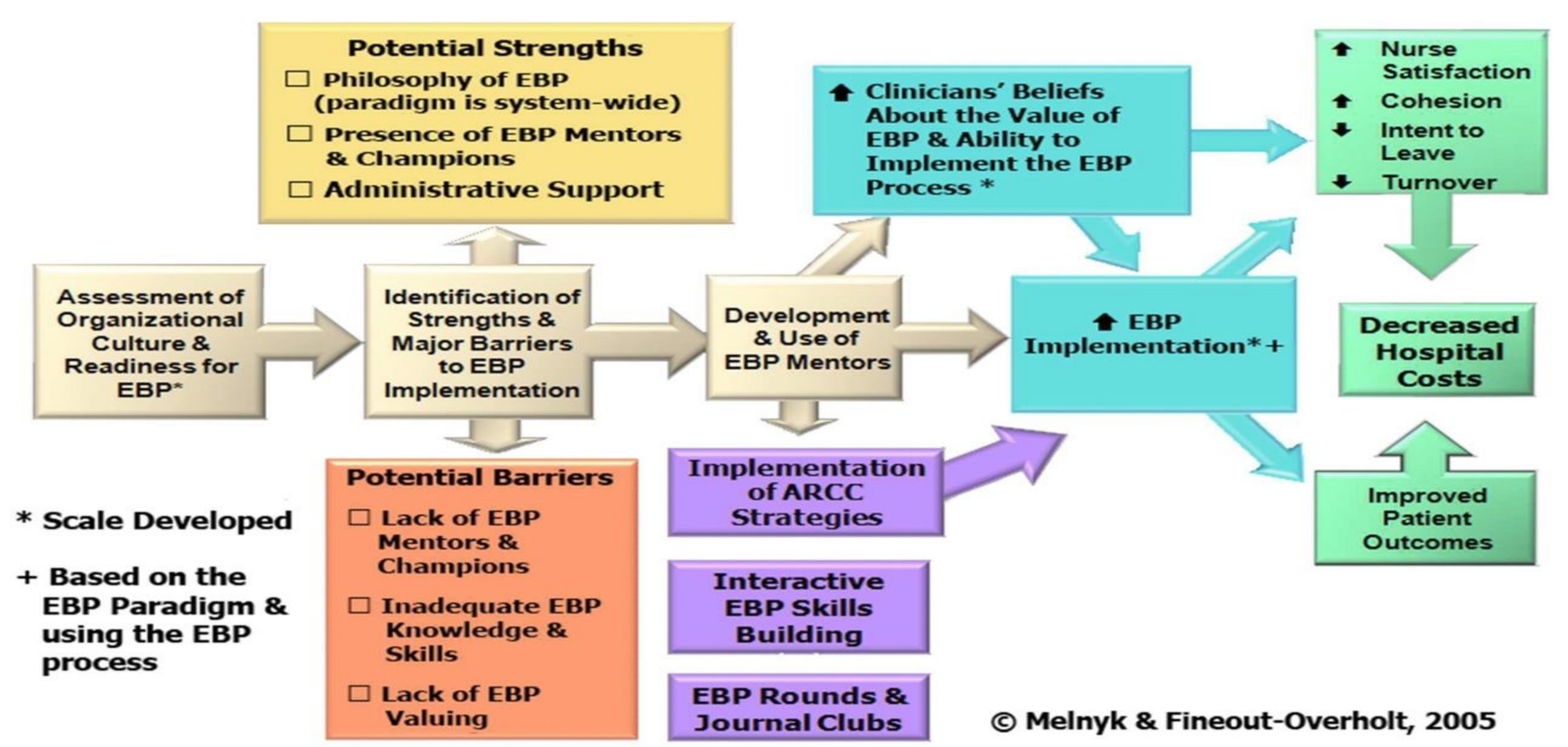
- **Ba giai đoạn**
  - Việc xác định một câu hỏi có thể trả lời được
  - Đánh giá có hệ thống và tổng hợp cả bằng chứng nghiên cứu và phi nghiên cứu
  - Dịch thuật bao gồm việc thực hiện thay đổi thực hành như một nghiên cứu thí điểm, đo lường kết quả và phổ biến các phát hiện

MGH Evidence-Based Practice Conceptual Model©



Adapted from Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Conceptual Model (2012)

Copyright 2016 MGH



ARCC Model (*Advancing Research and Clinical Practice*)

ARCC Model

Ứng dụng nghiên cứu và thực hành lâm sàng nâng cao

- ICU: ↓ số ngày thở máy từ 11,6 xuống 8,9 ngày, không có tràn khí phổi liên quan đến máy thở
- Tỷ lệ loét do tì đè ↓ từ 6,07% xuống 0,62%
- Giáo dục bệnh nhân suy tim sung huyết -> ↓ 14,7% số lần vào viện
- 75% bệnh nhân đánh giá chất lượng chăm sóc xuất sắc so với trước khi triển khai là 22,2 %

(*Melnyk và cộng sự, 2017*)

Washington Hospital Healthcare System

Mô hình EBP

- **IOWA Model**

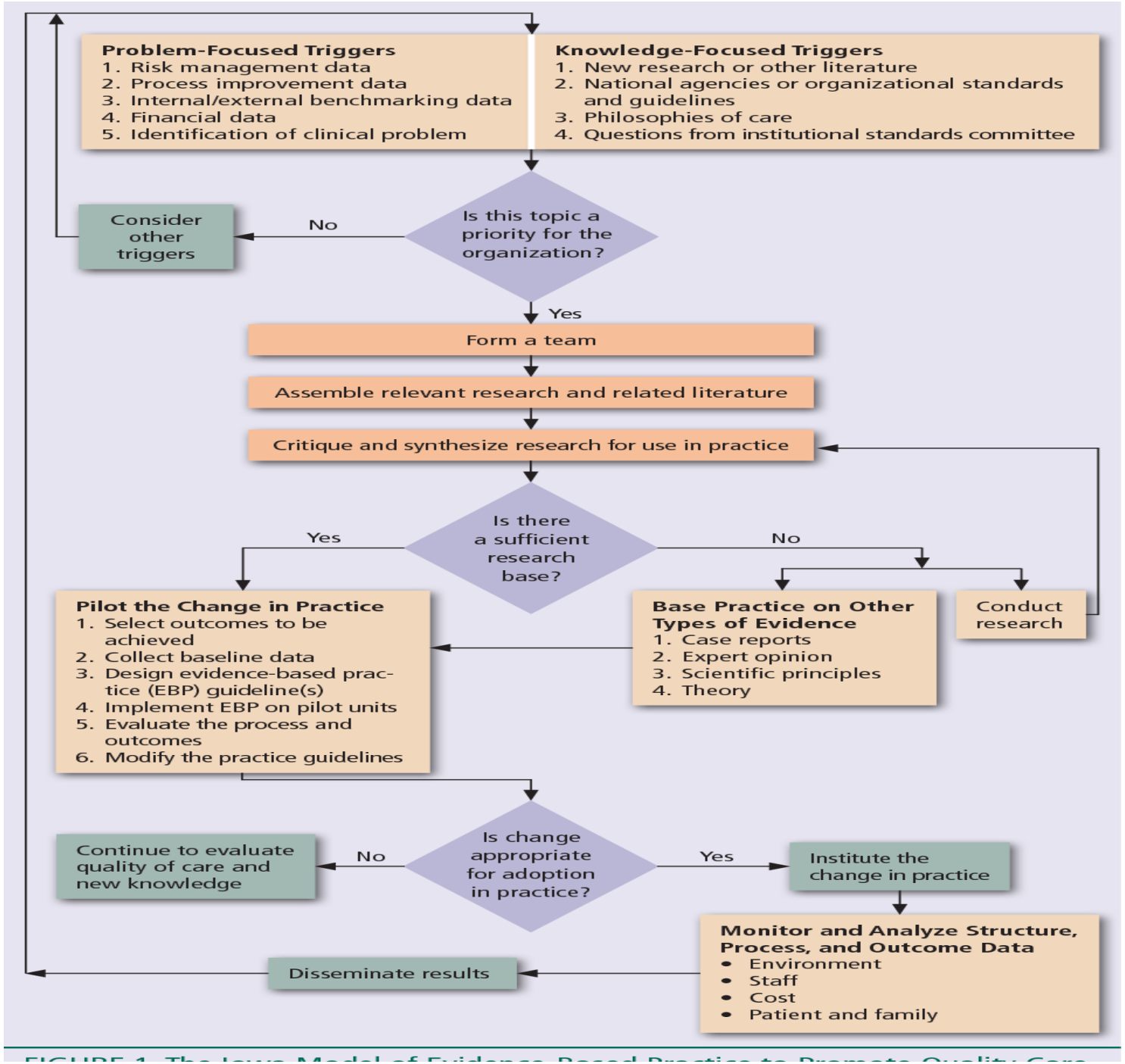
" Mô hình IOWA tập trung vào tổ chức và cộng tác kết hợp việc tiến hành và sử dụng nghiên cứu, cùng với các loại bằng chứng khác" (*Titler et al 2001*).

*** Điểm bắt đầu trong mô hình có thể là:**

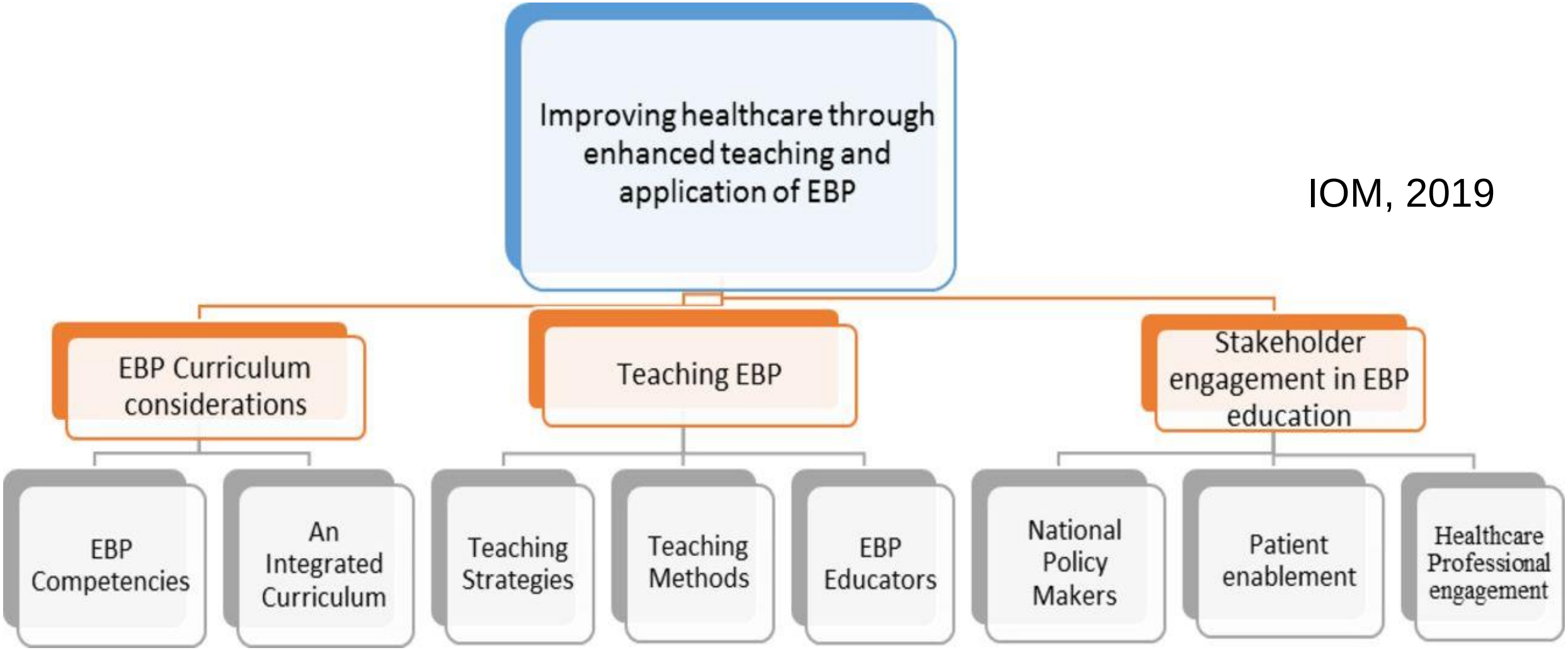
- Một yếu tố kích hoạt tập trung vào kiến thức (xuất hiện từ nhận thức về các phát hiện nghiên cứu sáng tạo)
- Một vấn đề - kích hoạt tập trung (có nguồn gốc từ một vấn đề lâm sàng hoặc tổ chức)

Mô hình EBP

- **Iowa Model**
  - Chọn chủ đề/vấn đề
  - Thành lập đội nhóm phối hợp thực hiện
  - Thu thập bằng chứng
  - Phân loại bằng chứng
  - Đánh giá và tổng hợp bằng chứng
  - Đề xuất khuyến nghị thực hành dựa trên bằng chứng
  - Phát triển thực hành dựa trên bằng chứng
  - Thực hiện và phổ biến thực hành
  - Thay đổi
  - Đánh giá sự thay đổi


Problem-Focused Triggers
1. Risk management data
2. Process improvement data
3. Internal/external benchmarking data
4. Financial data
5. Identification of clinical problem
Knowledge-Focused Triggers
1. New research or other literature
2. National agencies or organizational standards and guidelines
3. Philosophies of care
4. Questions from institutional standards committee
Is this topic a priority for the organization?
No
Consider other triggers
Yes
Form a team
Assemble relevant research and related literature
Critique and synthesize research for use in practice
Is there a sufficient research base?
Yes
No
Pilot the Change in Practice
1. Select outcomes to be achieved
2. Collect baseline data
3. Design evidence-based practice (EBP) guideline(s)
4. Implement EBP on pilot units
5. Evaluate the process and outcomes
6. Modify the practice guidelines
Base Practice on Other Types of Evidence
1. Case reports
2. Expert opinion
3. Scientific principles
4. Theory
Conduct research
Is change appropriate for adoption in practice?
No
Continue to evaluate quality of care and new knowledge
Yes
Institute the change in practice
Monitor and Analyze Structure, Process, and Outcome Data
• Environment
• Staff
• Cost
• Patient and family
Disseminate results

EBPC tích hợp các chương trình giáo dục đại học



IOM, 2019

EBP tích hợp các chương trình giáo dục đại học

- **Mục tiêu:**
  - Nâng cao kiến thức về EBP
  - Xây dựng ngôn ngữ về EBP
  - Phát triển kĩ năng về EBP
  - Tạo niềm tin và thái độ tích cực về EBP
  - Tạo ra sự nhất quán sớm vào EBP

Mô hình truyền tải EBP vào TH lâm sàng

- The Stetler Model of Evidence-Based Practice;
- The Iowa Model of Evidence-Based Practice to promote quality care;
- The Model for Evidence-Based Practice Change;
- The Advancing Research and Clinical practice through close Collaboration (ARCC) model for implementation and sustainability of EBP;
- The Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) framework;
- The Clinical Scholar Model;
- The Johns Hopkins Nursing Evidence-Based Practice Model;
- The Stevens Star Model of Knowledge Transformation

Yếu tố hỗ trợ phát triển

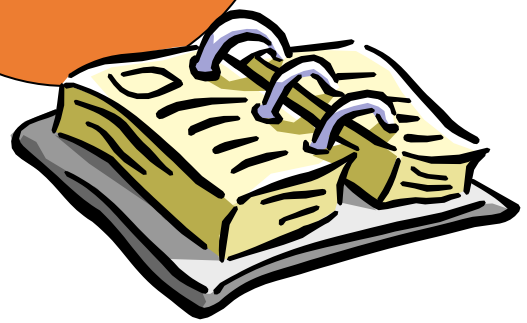
- Hỗ trợ và khuyến khích từ các nhà lãnh đạo và đồng nghiệp
- Đủ thời gian
- Cơ sở vật chất
- Cố vấn EBP
- Câu lạc bộ tạp chí, handout, bài báo đã công bố
- UptoDate

Kiến thức &Kinh nghiệm của BS/DD



EBP

Chứng cớ y văn



UptoDate

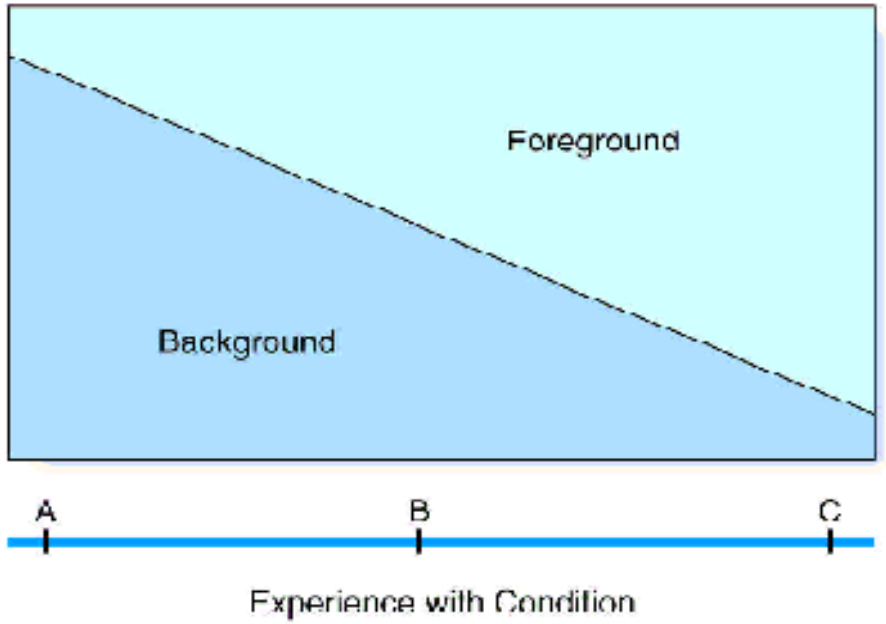
Lựa chọn của BN

Đặt câu hỏi
DOE -POEM

Asking answerable questions

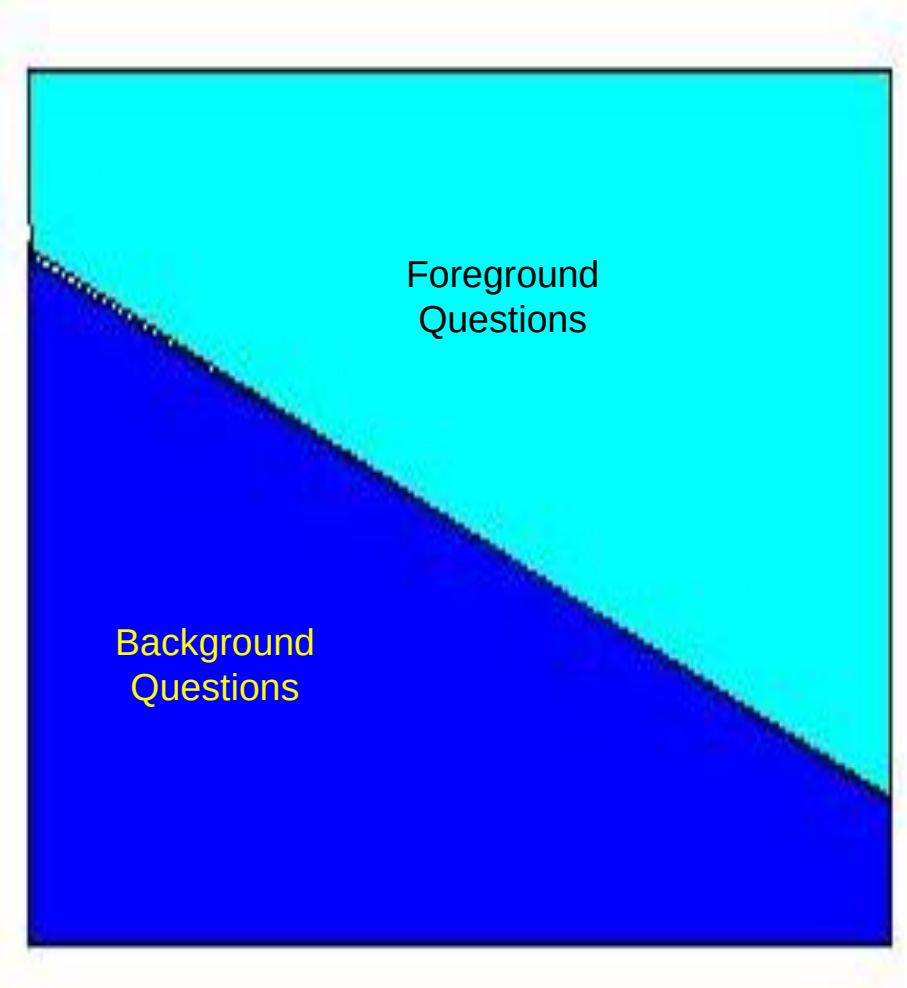
- **Background Questions**
  - •Asks for general knowledge
  - •Root (Who, What, Where, When, How…)
  - •Example: What causes pancreatitis?

- **Foreground Questions**
  - •Specific, managing a patient with a disorder
  - •Four components (PICO)
    - P - Patient and/or problem
    - I - Intervention
    - C - Comparison Intervention (if relevant)
    - O - Clinical Outcomes



A=Low experience

C=High experience



Medical students: (Background question)

- What is Kawasaki disease?
- What is the cause?
- What are symptoms & signs?
- What is the treatment?
- Cardiac involvement?

House officers (Foreground question)

In a child with Kawasaki disease, will repeated echo examination necessary for early detection of cardiac involvement? **(Dx)**

- In a child with Kawasaki disease in acute phase, does administration of Intravenous immunoglobulin decrease the likelihood of developing coronary involvement? **(Rx)**
- In a child with Kawasaki disease without coronary involvement in acute stage, does administration of long-term aspirin reduce the possibility of delayed coronary involvement? **(Px)**

Vấn đề của chúng ta ngày nay

- Chúng ta cần bằng chứng:
  - Độ chính xác của các test chẩn đoán
  - Mức độ tin cậy của các “dấu hiệu tiên lượng”
  - Hiệu quả và độ an toàn của các pp điều trị.

(Khoảng 5 lần cho mỗi bn nội trú và 2 lần cho 3 bn ngoại trú)

- Chúng ta chỉ thực hiện chỉ ít hơn 1/3

- Tần số các câu hỏi lâm sàng:Phòng khám:
- Phương pháp nhớ lại: Chambliss 1996 1 câu hỏi/ ngày
- Phương pháp quan sát: (1 câu hỏi/ 2 bệnh nhân) Covell 1995; 2 câu hỏi/ 3 bệnh nhânGorman 1995; 5,7 câu hỏi/ 10 bệnh nhân, Ely 1999 3,2 câu hỏi/ 10 bệnh nhân
- Khu bệnh phòng nội trú:Osheroff 5 câu hỏi/ 1 bệnh nhân trong một buổi học lâm sàng

Cho trẻ ngủ sấp hay ngữa?

- Các bác sĩ Tây phương trước đây khuyên nên cho trẻ ngủ sấp để tránh SIDS (sudden infant death syndrome)
- Thập niên 1980, một vài bác sĩ hoài nghi: Có bằng chứng nào ủng hộ việc ngủ sấp không?
- Vài nghiên cứu: nguy cơ SIDS ở trẻ ngủ ngữa giảm đáng kể → "Back to Sleep" program.
- Nếu có người nào đó hỏi câu hỏi này sớm hơn 20 năm, có thể cứu sống thêm vài ngàn đứa trẻ

DOE – POEM : đồng thuận

DOE	POEM
HCTZ controls blood pressure*	**HCTZ decreases mortality in patients with high blood pressure***
Ibuprofen decreases inflammation of osteoarthritis	**Ibuprofen improves pain and functional ability in patients with OA**

*** JNC VII. May 2003. Analgesia and non-aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs for osteoarthritis of the hip. The Cochrane Library, Issue 2, 2004.**

KHI MÀ DOE'S KHÔNG TRÙNG POEM'S

- YHCC = DTỄ -TKE + LS + BN
- Nếu bạn dùng thuốc chống đông
  - Nguy cơ đột quỵ của bạn trong năm tới sẽ giảm từ 6% xuống 2%

    nhưng
  - Nguy cơ bị xuất huyết nghiêm trọng của bạn gia tăng từ 1% lên 8%.

Chuyên gia dịch tễ không thể giúp bạn nữa rồi !!!! => kinh nghiệm BS địa phương

MÂU THUẨN VỚI HOÀN CẢNH

- Một ông cụ về hưu bị hen, ông sống cô đơn và coi con chó nhỏ trong nhà như là người thân của mình.
- Ông đến khám tại phòng khám của bạn, bạn sẽ cho lời khuyên như thế nào về việc nuôi chó của ông cụ?

Yếu tố rào cản

- Thiếu giá trị nghiên cứu trong thực tế
- Khó mang lại sự thay đổi
- Thiếu sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo, nhà quản lý
- Thiếu thời gian và kiến thức về nghiên cứu khoa học
- Báo cáo nghiên cứu không dễ có, độ phức tạp của báo cáo nghiên cứu
- Thiếu kiến thức về EBP
- Ngoại ngữ
- Thiếu thời gian

Hiểu chưa đúng

- 1. Y học chứng cứ không phải là bình củ và cũng như không phải là không thực hành được:
- 2. Y học chứng cứ không phải là sách dạy nấu ăn trong y khoa,
- 3. Y học chứng cứ không phải là biện pháp cắt giảm kinh phí y tế,
- 4. Y học chứng cứ không chỉ giới hạn bởi thử nghiệm lâm sàng và phân tích meta:
- 5. Y học chứng cứ thuộc dịch tễ học và thống kê

- Y HỌC CHỨNG CỨ THUỘC DỊCH TỄ HỌC => CHỈ HỌC MỘT LỚP LÀ ĐỦ
- Y HỌC CHỨNG CỨ LÀ TUYỆT ĐỐI KHI ÁP DỤNG VÀO THỰC HÀNH
- CHỈ CẦN MỘT NHÓM GIÚP THỰC HÀNH CHỨNG CỨ
- YHCC được viết trên đá

The Barriers to EBP

1. *Attitude of question & inquiry*
2. *Know-how in finding, appraising, and applying evidence*
3. *Information Resources on tap*
4. *Lack of Time*

Barriers to Translating Evidence into Practice

- Financial disincentives
- Lack of skills, facilities or equipment
- "Standard of Care" based on consensus
- Lack of knowledge – persons or experts
- Belief that "Guidelines" are cookbooks
- Misinformed lay public

Evidence Based Medicine

- *Opportunities*: 30 years of substantial reduction in infant mortality, due to high risk OB management, neonatal intensive care
- Remarkable reduction in risk of serious infectious diseases in childhood (H.flu, invasive pneumococcal disease, Hepatitis B)
- Successes in treatment of childhood cancers
- Increased prevalence of chronic illness
  - Asthma 3.7% in 1980, 12.7% in 2000
  - Obesity 5.7% in 1980, 15.3% in 2000
  - Autism
  - ADHD
  - Type II diabetes

The science – not as easy as it sounds

- Impractical to do randomized controlled trials (gold standard) on much of what is accepted practice
- Up to 1/3 of clinical trials lead to conclusions later overturned
  - Autologous bone marrow transplants in breast cancer
  - Tonsillectomies, pneumonostomy tubes in children
- Publication in a peer reviewed journal does not necessarily mean…
  - Sound methodology ; Study well conducted
  - Data analysis correct ; Interpretation of results correct
- Randomized controlled trial (RCT) may demonstrate efficacy (internal validity for the study population), but not necessarily effectiveness (external validity, general Applicability to broader population) in clinical practice.
- Need for “medicine-based evidence”, i.e. the impact of interventions as they are used in real life

The sociology:

- Evidence alone rarely leads to behavior change/change in practice
- Concerted efforts by medical groups, specialty societies, healthcare organizations to address barriers to adherence
  - Lack of awareness, agreement, familiarity
  - Inertia of prior practice
  - “What I do” vs “What I think I do”
  - Autonomy and discretion valued elements of professionalism
  - Patient expectations – covenant of trust – individualized treatment

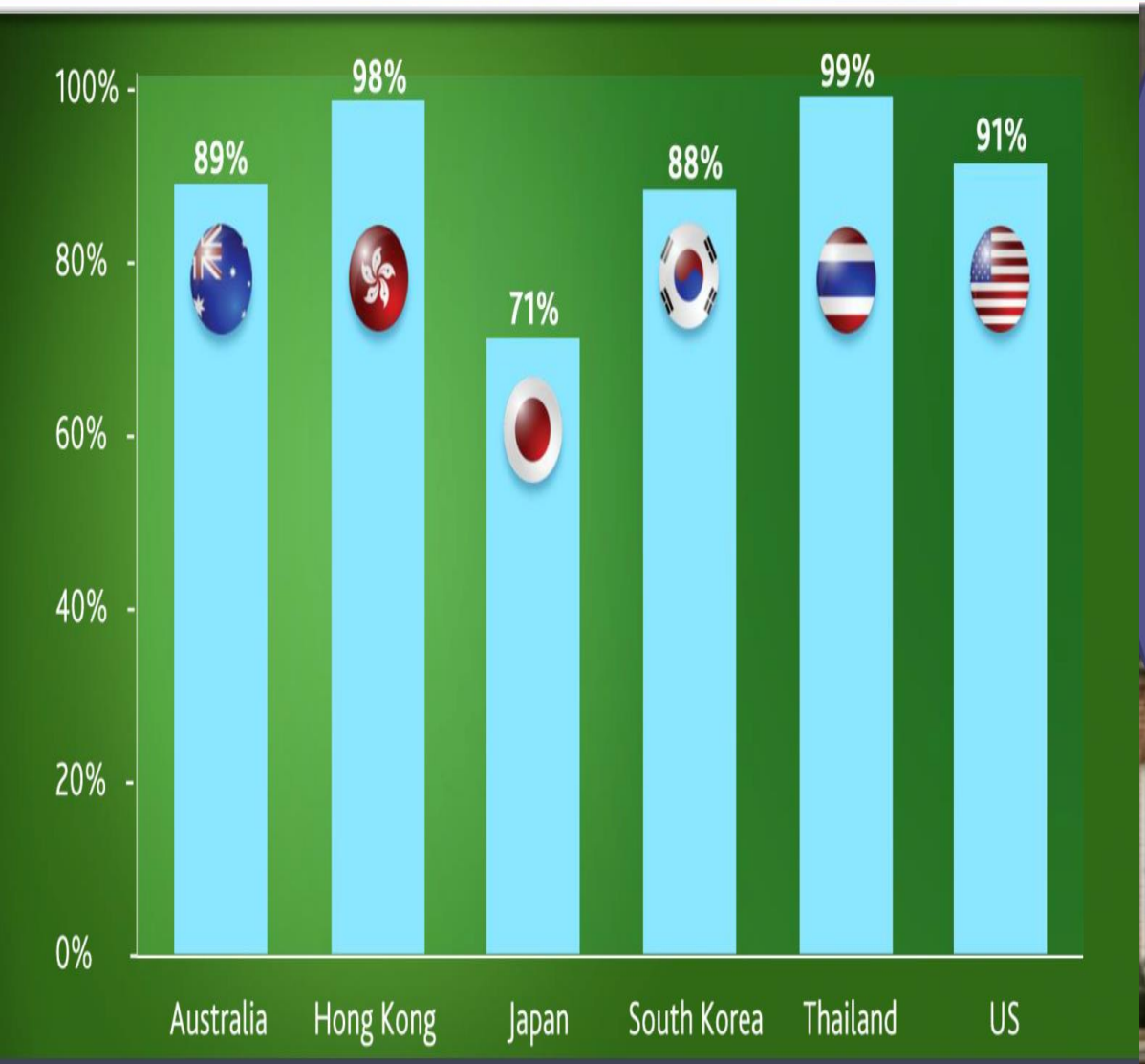
Evidence Based Medicine CHALLENGE

- 80% of all non-trauma-related spending for 20% of children with chronic illness
  - Focused efforts on guideline adherence - asthma
  - Multisectoral, behavioral and environmental intervention – obesity => MAKING DECISION + CHANGE BEHAVIOR => CULTURE – CLIMATE
  - Replicate the success for childhood cancer ("every child treated is a child studied") using EHR's, registries to address relatively rare, serious, complex conditions

- Generally, a blunt tool
- The "always harmful", "always beneficial" are easy – but only small percent of interventions
- Use of clinical guidelines: systematically developed, based on sound evidence, to assist practitioner and patient decisions for specific clinical circumstances: "using current best evidence in making decisions about care of individuals"
- Role of EHR's, registries, post-marketing surveillance in accelerating accumulation of evidence.
- As evidence base increases,? increasing opportunities for "criteria-based" coverage

Giải pháp tại Việt Nam

Clinicians Save Time with UpToDate



Percentage of users who report that UpToDate saves them time in answering clinical questions

The impact of UpToDate in different settings (NW UK)

The study was conducted in Pennine Acute Hospitals and The Christie NHS Foundation in Manchester, UK

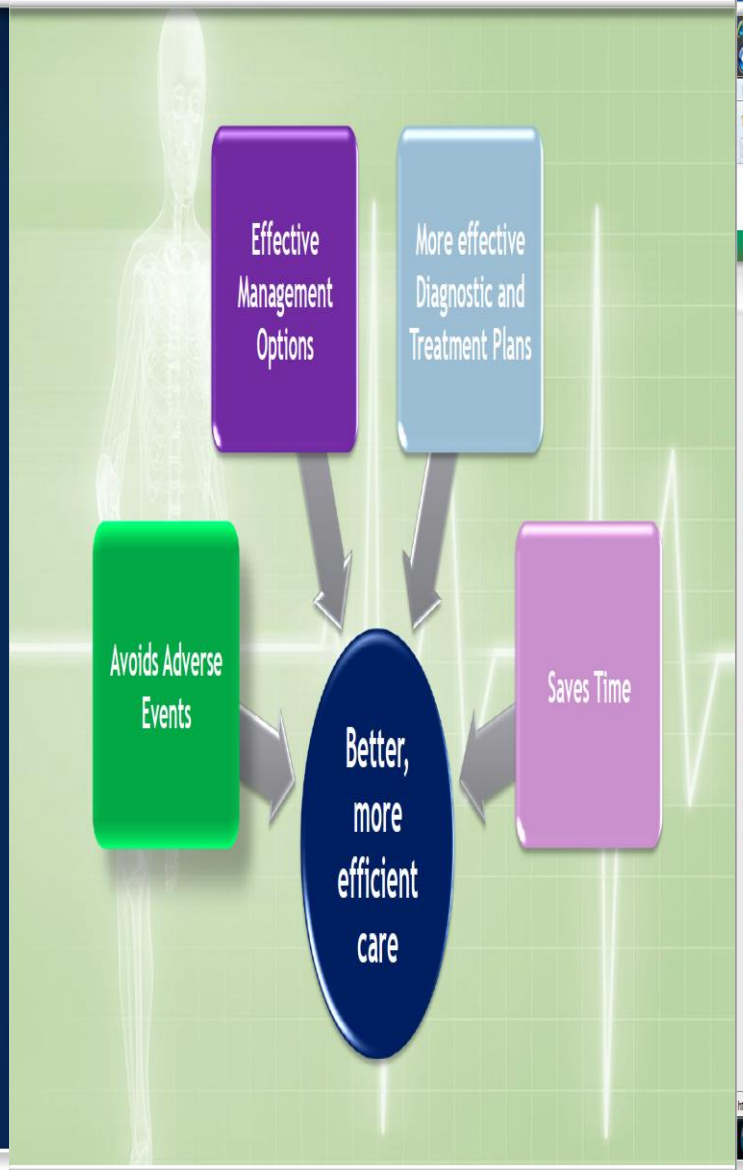
- Enables doctors to make the correct treatment decisions, and prevent death
- Enables direct cost savings to the organisation
- Enables doctors to reduce the delay in commencing treatment
- Enables the avoidance of unnecessary diagnostic tests
- Stops patients being referred to other colleagues for a 2nd opinion
- Enables doctors to obtain information about new treatments
- Enables the correct diagnosis to be made 1st time around
- Allows the doctor to give immediate patient feedback



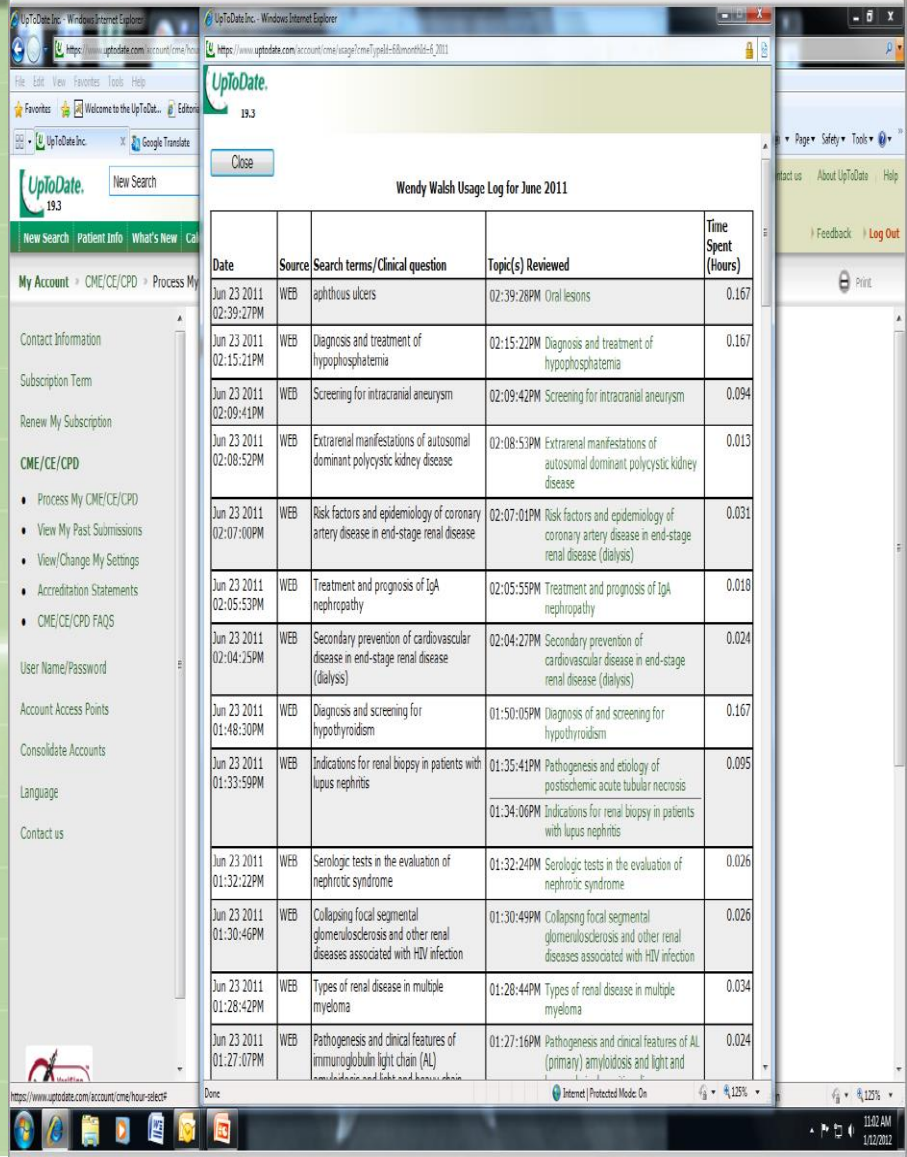
A New Way to Practice Medicine



Why UpToDate Improves Quality and Efficiency



Time based learning log



UpToDate. 19.3

Close

Wendy Walsh Usage Log for June 2011

Date	Source	Search terms/Clinical question	Topic(s) Reviewed	Time Spent (Hours)
Jun 23 2011 02:39:27PM	WEB	aphthous ulcers	02:39:28PM Oral lesions	0.167
Jun 23 2011 02:15:21PM	WEB	Diagnosis and treatment of hypophosphatemia	02:15:22PM Diagnosis and treatment of hypophosphatemia	0.167
Jun 23 2011 02:09:41PM	WEB	Screening for intracranial aneurysm	02:09:42PM Screening for intracranial aneurysm	0.094
Jun 23 2011 02:08:52PM	WEB	Extrarenal manifestations of autosomal dominant polycystic kidney disease	02:08:53PM Extrarenal manifestations of autosomal dominant polycystic kidney disease	0.013
Jun 23 2011 02:07:00PM	WEB	Risk factors and epidemiology of coronary artery disease in end-stage renal disease	02:07:01PM Risk factors and epidemiology of coronary artery disease in end-stage renal disease (dialysis)	0.031
Jun 23 2011 02:05:53PM	WEB	Treatment and prognosis of IgA nephropathy	02:05:55PM Treatment and prognosis of IgA nephropathy	0.018
Jun 23 2011 02:04:25PM	WEB	Secondary prevention of cardiovascular disease in end-stage renal disease (dialysis)	02:04:27PM Secondary prevention of cardiovascular disease in end-stage renal disease (dialysis)	0.024
Jun 23 2011 01:48:30PM	WEB	Diagnosis and screening for hypothyroidism	01:50:05PM Diagnosis of and screening for hypothyroidism	0.167
Jun 23 2011 01:33:59PM	WEB	Indications for renal biopsy in patients with lupus nephritis	01:35:41PM Pathogenesis and etiology of postischemic acute tubular necrosis 01:34:06PM Indications for renal biopsy in patients with lupus nephritis	0.095
Jun 23 2011 01:32:22PM	WEB	Serologic tests in the evaluation of nephrotic syndrome	01:32:24PM Serologic tests in the evaluation of nephrotic syndrome	0.026
Jun 23 2011 01:30:46PM	WEB	Collapsing focal segmental glomerulosclerosis and other renal diseases associated with HIV infection	01:30:49PM Collapsing focal segmental glomerulosclerosis and other renal diseases associated with HIV infection	0.026
Jun 23 2011 01:28:42PM	WEB	Types of renal disease in multiple myeloma	01:28:44PM Types of renal disease in multiple myeloma	0.034
Jun 23 2011 01:27:07PM	WEB	Pathogenesis and clinical features of immunoglobulin light chain (AL)	01:27:16PM Pathogenesis and clinical features of AL (primary) amyloidosis and light and	0.024

Kết luận



Thực hành dựa trên chứng cứ sẽ giúp điều dưỡng:

- Tích hợp bằng chứng hiện đại vào chăm sóc bệnh nhân
- Cập nhật tài liệu
- Nâng cao trình độ chuyên môn
- Cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân

THANKS!



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

(84-0292) 3 739 730

ctump@ctump.edu.vn

ctump.edu.vn

179 Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ